



CLINICAL MEDICINE

臨床醫學

*Clinical
Medicine*



CLINICAL MEDICINE

學號：

Vol.

姓名：

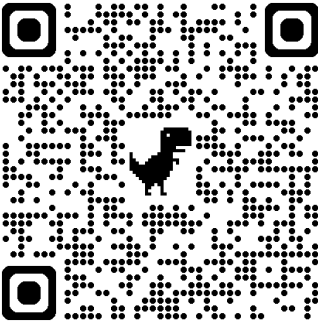
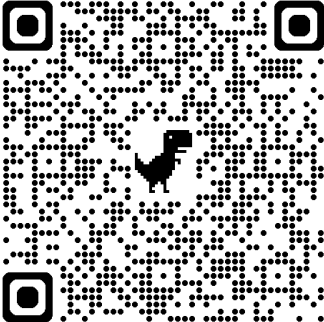
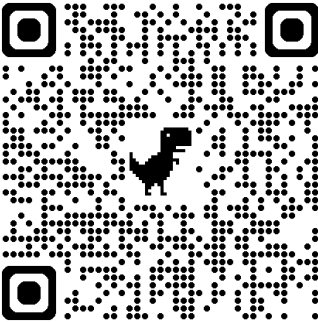
共筆製作群		
寫手：葉彥誼、蘇莘駿、高珮瑜、林欣綠、吳惠雯、曾資甯	組長：陳柏睿	共筆長：蕭婷云

重要公布事項：

寫手想跟你 / 妳各位說：

組長想跟你 / 妳各位說：

共筆長想跟你 / 妳各位說：

勘誤表單：	勘誤表	想說的話
		

臨床醫學共同筆記

第一次區段考古詳解 目錄

病史詢問與身體診察（不同老師）	2
面談溝通技巧	5
病歷書寫	7
病歷書寫（不同老師）	8
頭頸部的身體診察	10
手術前之評估及準備	12
微創及侵入性治療之反應	15
外科傷口之癒合（不同老師）	16
燒傷	20
B03 第一次區段考	25
B04 第一次區段考	29
B05 第一次區段考	34
B06 第一次區段考	37
B07 第一次區段考	41
B08 第一次區段考	44
B09 第一次區段考	46
B10 第一次區段考	51

病史詢問與身體診察（不同老師）

一、是非題

1-4	X	X	X	X
-----	---	---	---	---

二、單選題

1-10	C	D	A	無解	B	C	D	C	B	E
11-13	D	D	B							

三、是非題詳解

題號	答案	詳解
1	X	不必隱瞞醫學生身分、病人有拒絕的權利。 【出處】共筆 Vol.1 p.6
2	X	兩分鐘原則，因為病人容易歪樓，要學會適度歸納。 【出處】共筆 Vol.1 p.34
3	X	整合不同部位的症狀有助於診斷。 【出處】共筆 Vol.1 p.38
4	X	觸診、叩診和聽診之順序不太一定，例如腹部觸診後腸部蠕動的狀況已跟原本不同，要先聽後觸。 【出處】共筆 Vol.1 p.40

四、單選題詳解

題號	答案	詳解
1	C	六大核心能力：專業素養、醫學知識、病人照護、人際溝通技能、在工作中學習成長、制度下的臨床工作 【出處】共筆 Vol.1 p.7
2	D	需要將問診的資料經過消化整理後以時序重點寫出 【出處】共筆 Vol.1 p.38
3	A	(C) 觸診、叩診和聽診之順序不太一定，例如腹部聽診後腸部蠕動的狀況已跟原本不同，要視情況做調整。 【出處】共筆 Vol.1 p.40
4	無解	其實(B)選項還是有可能是甲狀腺癌，但是由於發生機率較低，所以硬要選只能選(B)。嚴格來說四個答案都是對的。
5	B	(A) 請尋求協助。 (D) 幫異性病人做 PE 時應該要注意，還是要有第三者在場。應該要看情況判斷。 (E) 在進行 history taking 的時候可以詢問。 【出處】共筆 Vol.1 p.6, 39

題號	答案	詳解
6	C	甲狀腺功能亢進症狀：脖子變粗、心跳加快、焦慮、容易緊張、手會抖、體重下降、多食、多汗、拉肚子、失眠。 【出處】生理學下共筆 Vol.3 p.21
7	D	(C) 也需要參考過去用藥，因為藥物交互作用可能影響治療效果、產生副作用或過敏（過去病史的一部分）。 【出處】共筆 Vol.1 p.36
8	C	(A) 不必隱瞞醫學生身分 (B) 請勿在教室外討論病情，並提到床號姓名 (D) 詢問 social and personal history 時可問及 (E) 因病歷電子化而容易貪圖方便複製貼上，但應該先詳閱先前病史，若不注意可能讓錯誤的病歷不斷沿襲下去 【出處】共筆 Vol.1 p.6
9	B	Sign：醫生診斷出的病徵。 Symptom：病人自覺的症狀。 體溫可觀測，屬於 vital sign。 【出處】07 共筆 Vol.1 p.26
10	E	學習三大重點：病史詢問、身體診察、病歷寫作。 六大核心能力：專業素養、醫學知識、病人照護、人際溝通技能、在工作中學習成長、制度下的臨床工作。 (E) 之後才要學 【出處】共筆 Vol.1 p.6
11	D	需要病人知情同意，同意書紀錄於病歷。 【出處】07 共筆 Vol.1 p.32
12	D	Sign：醫生診斷出的病徵。 Symptom：病人自覺的症狀。 (A)(B)(C)(E) 皆屬病人主觀感受，為 symptom。 (D) 反彈痛（rebound pain or rebound tenderness）：a clinical sign in which there is pain upon removal of pressure rather than application of pressure to the abdomen. 依據定義，反彈痛是醫生做理學檢查後觀測到的結果。 【出處】07 共筆 Vol.1 p.26
13	B	過去有高血壓可能會是鑑別診斷所需的依據，應補充入現在病史。 （一）包括症狀的自然史與相關病史： 將問診的資料經過消化整理後以時序重點寫出。注意追蹤症狀的演變，不要只有檢查資訊。症狀描述時，加入鑑別診斷的資訊。 （二）如過去病史，家族史或社會史如有相關，應該加入。

題號 答案

詳解

(E) (06 詳解) Icterus 查了網站與 Harrison，與 Jaundice 是一樣的定義，但 Harrison 中，icteric 這詞出現主要都是在講 Sclera 相關的症狀時才用，此或許為寫病歷時 Jaundice 在 Sclera 的病徵，主要就是用 Icteric 描述（可查 Harrison-Jaundice 章節）。

(07 詳解) (網路資料節錄) Yes, jaundice and icterus are one and the same. Jaundice is also known as ‘icterus’, which comes from the Greek word ‘icteric’. Icteric is a term that describes the yellow pigmentation of the skin, **the yellowing of the whites of the eyes**, and other mucous membranes in the body. Jaundice is derived from the French word ‘jaune’, which means yellow.

(<http://www.differencebetween.net/science/health/disease-health/differences-between-jaundice-and-icterus/>)

另外請教臨床醫學的老師，老師說 Jaundice 指的是膽紅素濃度升高，可以包含有皮膚變黃、鞏膜變黃、灰白大便等症狀；而 Icterus 則專指鞏膜泛黃這一件事。故病歷寫 Sclera：Icterus 較為正確。

【出處】共筆 Vol.1 p.36、37、38、網路資料、臨床課程

面談溝通技巧

一、是非題

題號	答案	詳解
1	X	人與人之間有一半的訊息傳遞是透過非語言的溝通，良好的溝通絕對不是只靠好的口才，事實上醫生的舉手投足都能讓病人感到安慰或是不安，這就是非語言的溝通技巧。
2	O	如上題詳解，溝通絕對不只是透過語言。
3	O	讓病人回答開放式問題為 patient-centered interview 的關鍵，在問診的最初，應選擇能讓病人自由發揮的開放式問答。
4	O	Anterior cingulate gyrus 屬於 limbic system ，和疼痛、情緒、記憶有關。病人來看醫生都是帶著情緒來的，醫生在鑑別診斷之餘也要照顧到病人情緒。
5	O	當代醫病關係的挑戰包括醫師有時須面對個體利益與群體利益之取捨問題，為一種當代醫病關係的挑戰。
6	O	根據 2010 年美國某研究之人員在病人出院前做的調查：在診斷之外，病人都希望自己的情緒與焦慮能夠獲得緩解，但在「病人覺得生病的情緒有被觸及嗎？」問題中，98%的醫師認為有觸及（老師表示自我感覺良好），但只有 46%的病人覺得有被觸及。
7	X	醫師在看病人時的習慣，會影響遭逢醫療糾紛的風險。相較於被投訴兩次以上的醫師，沒有病人投訴的醫師有：較長的看診時間、提供較多使病人了解看診程序的說明、幽默感與增加適當的微笑

二、單選題

題號	答案	詳解
1	D	挽回大眾對醫業的信任的方法：篩選並培育出一群醫療專業人員，他們視醫療為社會建構的一環，並知道如何傾聽與回饋，在他們自我許諾的特殊專業領域中，能 <u>清晰</u> 而誠摯地回應與溝通。
2	C	斷句與音調屬於副語言學面向。
3	B	(B) 戒急用忍！主訴後不應馬上詢問症狀發作的時間，應在整套症候群問完後再來詢問。 (A) Countertransference, which occurs when a therapist transfers emotions to a person in therapy, is often a reaction to transference, a phenomenon in which <u>the person in treatment redirects feelings for others onto the therapist.</u> (https://www.goodtherapy.org/blog/psychpedia/countertransference) (B) Somatization occurs when <u>psychological concerns are converted into physical symptoms.</u> For example, a person who has just lost a loved one may somaticize their grief through severe fatigue. The prefix “soma” stems from the Greek word for body. (https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/issues/somatization)
4	D	(C) Compliance is the process whereby the patient follows the prescribed and dispensed regimen as intended by the prescriber and dispenser. It is defined as “the extent to which a person’s behavior (in terms of taking medications, following diets, or executing lifestyle changes) coincides with medical or health advice. Compliance with therapy is an indication of a positive behavior in which the patient is <u>motivated sufficiently to adhere to the prescribed treatment</u> because of <u>a perceived self-benefit and positive outcome.</u> (https://www.uspharmacist.com/article/patient-compliance-and-health-behavior-models) 【出處】如上

病歷書寫

題號	答案	詳解
		(A)(D) 年齡寫法錯誤。 (B) 不要寫幾月幾號或是星期幾開始、而是寫「持續時間」
1	C	年齡寫法： 例如：I'm 32 years old. (我32歲) → I'm a 32-year-old engineer. (我是個32歲的工程師) 可參考此NEJM病歷之寫法 https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMcpc2107350 【出處】共筆 Vol.1 p.25，以上網址
2	C	Chief complaint → Present illness (包含 Review of system) → Past history (包含 Personal history、Family history) → Physical exam → Laboratory findings → Medical imaging → Diagnosis → Management plan。 【出處】共筆 Vol.1 p.25
3	E	LQQOPERA：Location、Quality、Quantity、Onset mode、Precipitating factors、Exaggerating factors、Relieving factors、Associated symptoms。 【出處】共筆 Vol.1 p.27
4	C	(非本次內容) 脾臟位於左側，故 splenic infarction 比較不會造成右側 scapula 疼痛。 【出處】大三解剖學

病歷書寫（不同老師）

題號	答案	詳解
1	X	病歷有一定書寫格式、內容規範，以利其他醫師了解病人病情。【出處】共筆 Vol.1 p.22
2	D	(A) Chief complaint (主訴)：病人此次來就醫的病症為何。本身對病況的描述，可以不只一個。 (B) Informant (病情告知者)：通常是病人本身，但有些病人不一定有能力告知 (如意識不清、語言不通等)，此時病情告知者可能是病人的家人或其他代理人。若非本人描述，需判斷並擷取正確資訊。 (C) 藥物食物的過敏史一定要問且記錄下來！ 【出處】共筆 Vol.1 p.25
3	A	(B)(C) 症狀要加持續時間(duration)，算法是從症狀產生到入院的時間。 (D) 盡量引用病人的話，避免使用醫學專有名詞；又 renal colic 為醫學專業名詞，故不適合。 【出處】共筆 Vol.1 p.26
4	C	Progress note 的重點在於 Assessment，包括診斷、鑑別診斷、診斷依據、評估指標以及病情評估。 【出處】共筆 Vol.1 p.32
5	B	(A) 沒有提及症狀嚴重性。 (C) 沒有提及明確症狀頻率、嚴重性。 (D) 沒有提及明確症狀嚴重性。 【出處】共筆 Vol.1 p.22
6	A	(A) 醫師法規定要寫：《醫師法》第 12 條：「醫師執行業務時，應製作病歷，並簽名或蓋章及加註執行年、月、日。」 【出處】共筆 Vol.1 p.22
7	C	(A) Informant (病情告知者)：通常是病人本身，但有些病人不一定有能力告知 (如意識不清、語言不通等)，此時病情告知者可能是病人的家人或其他代理人。若非本人描述，需判斷並擷取正確資訊。 (B) Chief complaint (病患主訴)：病人此次來就醫的病症為何。本身對病況的描述，可以不只一個。 (C) 不用記錄病患薪水。 (D) 目前使用的藥物，因為藥物交互作用可能影響治療效果、產生副作用或過敏。 【出處】共筆 Vol.1 p.25
8	B	症狀要加持續時間(duration)，算法是從症狀產生到入院的時間。不要寫幾月幾號或是星期幾開始、而是寫「持續時間」

題號	答案	詳解
【出處】共筆 Vol.1 p.26		
9	A	四項內容： 1. 診斷之時、地、依據 2. 治療及效果 3. 併發症 4. 伴隨狀況 【出處】共筆 Vol.1 p.29

頭頸部的身體診察

1-10	D	A	A	A	C	D	E	A	D	B
11-17	E	E	C	B	A	B	ABD			

題號	答案	詳解
1	D	小孩頭頸部淋巴腫時需做 FNAC 的可能因素包含給予抗生素治療無反應、腫塊持續變大、單顆不對稱腫塊、supraclavicular 腫塊、長期存在的腫塊但沒有感染跡象；至於多個淋巴結腫大則常常是感染造成。 【出處】共筆 Vol.1 P.23
2	A	在小孩中，惡性的機率較高，且大部分是男生。至於在成人中雖然良性的機率比較高，但是患者則以女性為主。 (D) 對於甲狀腺腫瘤，超音波是首選。 【出處】共筆 Vol.1 P.20,24
3	A	頭頸部惡性淋巴瘤在成人指的多半是 non-Hodgkin's lymphoma，常見伴隨 lymphadenopathy、hepatosplenomegaly、fever、weight loss、night sweats。 可以注意到上述是所謂 B symptoms FNAC 不適合用於 lymphoma 的診斷。 【出處】共筆 Vol.1 P.25
4	A	台灣是 Nasopharynx，國外是 tonsil。 【出處】共筆 Vol.1 P.22
5	C	(A)(B)(D) Typical <i>M. Tuberculosis</i> 好發於成人，node 常出現在 posterior triangle，對藥物反應良好。 Atypical <i>M. tuberculosis</i> 好發於小孩，node 多長在 anterior triangle，皮膚會變色，會變成硬結而且會有疼痛感，藥物治療通常無效需開刀切除。 (C)(E) Malignant tumor（如 lymphoma）或 granulomatous disease（如 TB）不易被 FNAC 細針穿刺細胞檢查診斷出來，需做切片 open excisional biopsy。 (E) TB PCR(Biopsy) is performed to confirm Tuberculosis and also during the treatment and after the treatment of Tuberculosis 【出處】共筆 Vol.1 P.24、 https://www.lybrate.com/lab-test/tb-pcr-biopsy

6	D	老師上課有說跟 thyroid 有關的腫塊，通常吞嚥時都會上下移動。 需連舌骨一併切除因為很容易清不乾淨。 【出處】共筆 Vol.1 P.29
7	E	Lymphangioma 出現在 supraclavicular nodes (IV、V 區)。 【出處】共筆 Vol.1 P.32、33
8	A	Ia 區。 【出處】共筆 Vol.1 P.31
9	D	Neurogenic tumor 中的 Schwannoma 好發於脖子正中 poststyloid 的位置，為最常見的 parapharyngeal tumor (側咽部腫瘤)，稱之 medial tonsillar displacement 【出處】共筆 Vol.1 P.27
10	B	【出處】共筆 vol.1 P.18、19、20
11	E	Unilateral serous otitis (單側積液性中耳炎)，懷疑是 nasopharynx primary。 【出處】共筆 Vol.1 P.21
12	E	單側轉移性耳痛為鼻竇、唾腺和咽部感染的常見症狀，所以以上位置皆要檢查。注意到 nerve 7,9，顯然。 【出處】共筆 Vol.1 P.21
13	C	FNAc 是最重要的頭頸部腫塊檢驗工具。 【出處】共筆 Vol.1 P.18
14	B	應為 posterior triangle nodes。 【出處】共筆 Vol.1 P.24
15	A	最常見的 Congenital mass 是粉瘤 (Sebaceous cysts)。 【出處】共筆 Vol.1 P.19
16	B	(B) 應為 facial nerve。 (E) 好發於低年齡層。 【出處】共筆 Vol.1 P.28
17	ABD	腫瘤快速長大、腫瘤和皮膚粘黏 (skin fixation)、顏面神經麻痺 (facial palsy) 皆為 salivary gland tumor 良性轉惡性的徵象。疼痛則沒有絕對關係。 【出處】共筆 Vol.1 P.15

手術前之評估及準備

1-8	E	E	C	A	E	A	B(BD)	A
-----	---	---	---	---	---	---	-------	---

題號 答案

詳解

1 E 相較起來風險最低。

2 E (B)(D) 為基本檢查，全身麻醉或局部麻醉需做胸部 X 光，大於 45 歲需做心電圖。
(E) 小於 4 才需要做心臟超音波。

(A) 沒有 MI 病史者術後發生 MI 機率 0.1 - 0.6%，但曾有 MI 病史者術後發生 MI 機率增加十倍變 2.8 - 7%。

(B) 此病患狀況不佳，可以直觀推測不太容易有這麼低的術後呼吸衰竭率。據 Arozullah 風險評估，此病患（年紀 > 70）6+（上腹部手術）14+（BUN > 30）8+（COPD 病史）6 = 34 為 Class 4，發生呼吸衰竭機率為 10.1%。Class 1 發生率才會小於 0.5%。

Arozullah Respiratory Failure Risk Index

3 C

Type of Surgery	Point Value	Class	Point Total	Respiratory Failure %
• AAA	27			
• Thoracic	21	One	<= 10	0.5
• Neurosurgery, Upper Abdominal, Peripheral Vascular, Neck	14	Two	11 - 19	1.8
		Three	20 - 27	4.2
• Emergency Surgery	11	Four	28 - 40	10.1
• Albumin < 3.0 g/dL	9	Five	> 40	26.6
• BUN > 30 mg/dL	8	Low Risk		
• Partial/Full Dependence	7	Arozulla 1		To OR
• History of COPD	6	Intermedium Risk		
• Age > 70	6	Arozulla 2 - 3		Consider Further Testing CXR, PFT if will change management
• Age 60 - 69	5	High Risk		
		Arozulla >= 4		Reconsider surgery Shorter Procedure Spinal or Epidural

Arozullah AM, Daley J, et al, Ann Surg 2000; 232:242



(C) 六個月內有 MI、高齡、Cr > 2mg/dl、functional capacity < 4 MET，術後心臟疾病風險高；患 COPD 術後肺部疾病風險高。應延遲手術。

題號 答案

詳解

(D) 根據 ASA 評估表，Class I 為健康病人，此病人應屬 ASA 第 3 級，可再評估延期手術之可能。

Classification of Operative Risk (American Society of Anesthesiologists)	
Normal healthy patient	0.01%
Patient with mild systemic disease	0.1%
Patient with severe disease that limits activity but is not incapacitating	1%
Patient with an incapacitating disease that is a constant threat to life	10%
Moribund patient not expected to survive 24 hours with or without surgery	50+%
E1, E2, etc. In the event of emergency surgery, the prefix E precedes the number.	
Percentages given in this table are gross overall estimations of mortality based on disparate clinical reports. The actual mortality rates vary substantially depending upon the nature of the surgical procedure, age of the patient, and type of anesthesia.	

4 A

ASA 以病人手術前之健康狀況大致評估手術風險，本例病人健康，屬於風險最低之 Class I。

5 E

(A)(B)(C)皆對，(D)未提。

【出處】07 沒講，06 共筆也沒看到

注意「腸胃道、膽道、生殖道、呼吸道」等向外開口管道是髒污地區。完全沒有接觸上述區域的手術傷口是 clean，题目的脾臟切除手術屬於此類。

有切到或接觸到上述區域但沒有擠出內含物，為 clean-contaminated。術中切在髒汙區的大傷口等都是 contaminated。持續泡在污物內的傷口就是 dirty，像是大腸造口、切開組織排膿。

6 A

Type of procedure	Definition	Wound infection rate (%)	Example	Need for prophylaxis
Clean	Atraumatic; no inflammation encountered, no break in technique; gastro-intestinal, genitourinary and respiratory tracts not entered	1.5-4.2	Inguinal hernia repair	Not usually required
Contaminated	Gastro-intestinal or respiratory tract entered but without spillage; oropharynx, appendectomy, sterile genitourinary or biliary tract entered; minor break in technique	<10	Cholecystectomy (no spillage)	Usually required
Clean-contaminated	Acute inflammation; infected bile or urine; gross spillage from gastro-intestinal tract; major lapse in technique; fresh traumatic wound (12-24 h)	10-20	Appendectomy	Required
Dirty and infected	Established infection; transection of clean tissues to enable collection of pus; traumatic wound with retained devitalised tissue; faecal contamination; delayed treatment	20-40	Sigmoid colectomy (Hartmann's procedure) for faecal peritonitis	Treatment required (not prophylaxis)

【出處】07 沒教

7	B or BD	原本答案出於不明原因只給 B。 (A) 前八週就要開始戒煙。 (B) 氣喘、COPD、慢性咳嗽、呼吸困難、抽煙、肥胖、obstructive sleep apnea 或進行胸部腹部手術的病患，都建議使用 incentive spirometry 或進行 Deep breathing exercise 等呼吸訓練以降低肺部併發症。 (C) 在肺部併發症部分沒有提到低血容對其影響。 (D) 要，不然要讓他繼續感染嗎？
8	A	沒有 MI 病史者術後發生 MI 機率為 0.1 - 0.6%，但曾有 MI 病史者術後發生 MI 機率增加，變 2.8 - 7%。

微創及侵入性治療之反應

題號	答案	詳解
1	B	受傷後身體能量需求增加，需要增加血糖等物質，所以 (A) Cortisol、(C) Glucagon、(D) Catecholamine 增加。
2	B	傷口會造成內皮細胞、巨噬細胞、淋巴球、纖維母細胞等釋放發炎介質，促進傷口復原和修復。發炎介質包含：IL-1、IL-6、TNF。而 IL-2 與 T cell 增生相關。
3	C	加速術後恢復的因素：early feeding、minimal invasive operations（透過微創手術達成）、correcting nutrition defect 等；減緩術後恢復的因素：氧氣不夠、preoperative organ dysfunction、hypothermia、surgical stress response、nausea vomiting sleep disturbance、drains、NG tube、catheters。
4	C	達文西機械手臂有如下優點： 3D 高畫質的成像（相較於腹腔鏡的 2D 畫面）、高穩定度（相較於腹腔鏡手術由人手持攝影鏡頭與器械）、靈活（廠商標榜轉 540 度）。 缺點則是：價格昂貴（進口）、缺乏實體觸感（可以透過肉眼、經驗克服）、機械器材也仍在發展中。
5	D	微創手術的其他優點包含： Reduce surgical trauma and inflammatory stress response、Improved surgical immunity、Less patient discomfort、Facilitated rehabilitation、Improved cosmetics of surgical wound、Reduced duration of hospital stay、Abdominal wall saving、Reduced adhesions。

外科傷口之癒合（不同老師）

1-10	C	A	B	D	B	A	E	C	A	B
11-17	E	B	B	B	A	B	AC			

題號 答案

詳解

1	C	傷口發生之後最主要的反應是止血；接下來免疫系統清除 pathogens；最後是靠纖維母細胞（fibroblast）及膠原蛋白（collagen）來做修復。 【出處】08 共筆 Vol.3 P.15		1. 傷口出血部位、血小板凝聚收縮止血 2. 白血球在創床活動 3. 巨噬細胞在創床活動 4. 表皮細胞增生覆蓋創面 5. 纖維母細胞與膠原蛋白纖維生成。 6. 微血管增殖。
2	A	(A) 乾燥的環境會使創面上皮細胞增生停止，乾燥壞死。 【出處】08 共筆 Vol.3 P.22		
3	B	感染、組織壞死或缺血、營養不良都會影響傷口。 急性創傷則不一定是不利因子。 【出處】08 共筆 Vol.3 P.24		
4	D	(A) 生理食鹽水可用來清潔傷口。 (B) 移除所有異物及壞死組織，保持乾淨的環境可以加快傷口癒合。 (C) 組織對齊，傷口才能恢復成接近原本的樣子。 (D) 有感染的機會，應先清理。 【出處】08 共筆 Vol.3 P.21, 22		

題號 答案

詳解

傷口癒合的分類：

- 5 B
1. Primary healing：傷口狹窄整齊，直接縫合可處理。
 2. Delayed primary healing：較不乾淨的傷口，人咬傷屬於這種。
 3. Secondary healing：Healing by wound contraction and epithelization，會形成 granulation tissue，容易有 scar。
 4. Healing of partial-thickness wounds：部分 dermis 仍保留著，healing by re-epithelialization，擦傷、淺層燒傷這類的淺層傷口，healing 效果較 secondary healing 來得好。

【出處】08 共筆 Vol.3 P.16

- 6 A
- (A) 乾燥環境下細胞無法成長，傷口難癒合。
- 【出處】08 共筆 Vol.3 P.22

- 7 E
- (A) 止血 (Coagulation)：第 0-2 天時，血小板會聚集沉澱在受傷血管壁上，並且釋放 alpha granules 中的 PDGF / TGF-beta 等吸引活化纖維母細胞、血管內皮細胞、巨噬細胞。
- (B) 發炎 (inflammation)：發炎早期（第 1-2 天）補體系統中的 C3a, C5a 會吸引嗜中性白血球，白血球經 rolling, adhesion, migration, chemotaxis 等過程後，可以清除外來細菌與壞死的細胞（可搭配病理 Robbins 10 ed. Ch3）。
- (C) 發炎晚期（第 2-3 天）單核球會跑到組織轉變成巨噬細胞，繼續清除異物並分泌生長因子活化血管內皮細胞、纖維細胞、平滑肌細胞以助癒合。
- (D) 第 3-8 天淋巴球才出現，跨發炎晚期與傷口增生早期調控膠原與胞外間質的形成。
- (E) 各自的功能如上，皆明顯。
- 【出處】08 共筆未提

- 8 C



發炎晚期（第 2-3 天）單核球會跑到組織轉變成巨噬細胞，繼續清除異物並分泌生長因子活化血管內皮細胞、纖維細胞、平滑肌細胞以助癒合。也可以參考病理 Vol. 3，應該是巨噬細胞分泌最多生長因子。

題號	答案	詳解
		【出處】08 共筆未提；https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2670976/
9	A	(A) 增生期的時期中，纖維母細胞受到巨噬細胞分泌在傷口的生長因子所吸引，開始促進傷口新生。在 5~7 天會開始生成膠原（collagen）和細胞外間質，這過程將持續 2 到 3 個星期。 (B) Desmin：肌肉細胞表現的中間絲蛋白。 (C) Epithelium：此過程表皮細胞也會爬行或增生到傷口處，但不是最主要的過程。 (D) Fibronectin：細胞間質的成份之一。纖維母細胞會分泌 hyaluronidase 分解 hyaluronic acid（細胞間質的另一成份），並藉由所剩的 fibronectin 和 glycosaminoglycan 當成鷹架，開始生成膠原，產生疤痕組織。 (E) Growth Factor 血小板在止血時分泌；或巨噬細胞在發炎時期分泌。 【出處】08 共筆未提
10	B	因為感覺神經麻痺，糖尿病患很容易忽視足部被壓迫到或有異物造成傷口，再加上糖尿病患癒合能力不佳，傷口照顧不好很容易發展成糖尿病足部慢性潰瘍 diabetic ulcer。解決方式為使用六週的石膏（total contact cast），但現實生活中難以執行。 【出處】08 共筆未提
11	E	(A) 正確。 (B) 在骨頭隆起處組織很容易受到壓迫。 (C) 除了長期肢體活動不良(例如脊髓損傷者)，長期臥床、意識不清楚、大小便失禁、有糖尿病或皮膚脆弱、體力衰弱或營養不良的患者也容易發生。 (D) 正確。 (E) 定期翻身、注意皮膚清潔都可以預防褥瘡。 【出處】08 共筆未提
12	B	(A) 達不到一百萬。 (B) 是的，所以要止血、清瘡、取出異物。 (C) 術前幾小時才對。 【出處】08 共筆未提
13	B	(A) 不會。 (B) 不該靠一般手術處理，可以使用冷凍手術法或 laser。 (C) 不對，還是有 scars。

題號 答案

詳解

(D) 3M 美容紙膠 (Sterilstrip)：保護傷口、透氣、可碰水，使張力均勻分散，但要注意別貼到眉毛，撕掉長回來要很久。每週換一次即可，不可天天更換以免造成傷害

【出處】08 共筆未提

14 B

(A) 術前再剃就好。

(B) 把細菌沖走 (cleansing)。

(C) 術前 (血液中才會有抗生素)。

(D) 不一定，看傷口的癒合度，再來決定需不需要做別的 procedure 或換藥。

【出處】08 共筆未提

15 A

電燒止血效果良好，大部份不用放引流管。引流管可引流血水、膿液，避免壓迫、刺激周圍器官，預防感染並促進傷口癒合。即使仔細電燒有時還是需放引流管。

【出處】08 共筆未提

16 B

傷口癒合的分類：

1. Primary healing：傷口狹窄整齊，直接縫合可處理。

2. Delayed primary healing：較不乾淨的傷口，人咬傷屬於這種。

3. Secondary healing：Healing by wound contraction and epithelization，會形成 granulation tissue，容易有 scar。

4. Healing of partial-thickness wounds：部分 dermis 仍保留著，healing by re-epithelialization，擦傷、淺層燒傷這類的淺層傷口，healing 效果較 secondary healing 來得好。

【出處】08 共筆 Vol.3 P.16-18

17 AC

(A) 有四種：primary wound healing, secondary wound healing, delayed primary wound healing 和 partial thickness wound。

(B) 參考下圖。

(C) 第一階段是止血。

(D) 因為這段時期大量產生 collagen 以癒合傷口，亦有彈性。

【出處】08 共筆 Vol.3 P.16-18,21,22

Healing Mechanism	Types of Wound		
	Suture (Primary Intention)	Open (Secondary Intention)	Partial-Thickness
Contraction	0	+++	0
Epithelialization	+	++	+++
Connective tissue deposition	+++	++	0

燒傷

一、單選題

1-10	C	B	D	B	B	D	B	E	C	C
11-13	D	A	B							

二、多選題

1-4	BDE	CD	CD	BCD
-----	-----	----	----	-----

三、單選題詳解

題號	答案	詳解
1	C	Modified BAUX score，考慮年齡、吸入性灼傷、燒傷面積，若病患超過 60 歲、TBSA 超過 60% 且有吸入性灼傷，死亡率高達 95%。 (注意燒傷深度沒有列在考慮範圍內)。 【出處】08 共筆 Vol.3 P.40
2	B	每小時監測尿量。 通常是每公斤每小時，小便的量 0.5 ~ 1.0 c.c./kg/hr，若出現血尿則小便要維持在每小時 100 c.c. 以上。 【出處】08 共筆 Vol.3 P.39
3	D	深二度燒傷以上，外觀是雜色或燒焦的顏色，而要盡快植皮，否則疤痕攣縮會痛會癢，影響關節活動。 D：淺二度 【出處】08 共筆 Vol.3 P.30,35
4	B	全層（三度）燒傷看起來整個硬梆梆的，就像烤肉一樣燒焦、脫水，沒有彈性也沒有水泡。可能不會自己好需要植皮，會有疤痕肥厚影響關節活動。 【出處】08 共筆 Vol.3 P.30

題號 答案

詳解

燒傷病患需要住加護病房的標準為：

1. 10 歲以下小孩或 50 歲以上成人，2 度或 3 度燙傷 >10%TBSA。
2. 任何年紀，2 度或 3 度燙傷 > 20% TBSA。
3. 燒傷部位為：顏面、手掌、腳掌、會陰、主要關節。
4. 化學燒傷、電傷、吸入性灼傷。
5. 任何 2 度或 3 度燙傷併有創傷。
6. 燒傷加上其他疾病。

5 B

此題中 (A) 20% TBSA 燒傷比起 (B) 0% TBSA 燒傷嚴重很多。雖然題目沒有標明是幾度灼傷，但燒傷面積和存活率有很大的關係。而 (C)(D) 選項，無論是化學性灼傷或電傷都要去加護病房觀察，是故選 (B) 較合適。

【出處】08 共筆 Vol.3 P.29,36

6 D

學長姊留下的口訣：一路發，TNF 也發。

【出處】08 共筆 Vol.3 P.36

7 B

(B) 1~1.5 倍。

【出處】08 共筆 Vol.3 P.37

8 E

(A)TNF 使血管通透性上升，正確。

(B)(C) 燒傷後皮膚會失去體溫調節功能，造成體溫改變。只要 < 38.5 均屬正常可接受。

可能 hyperthermia 係因壓力反應使體溫調節點上升、有高代謝率，並且皮膚受損失去排汗功能，無法散出能量，體溫會上升。

可能 hypothermia 係因缺乏皮膚保護及熱調節功能，老師上課時有舉例患者到院體溫 35 度。更多例子與討論可見本篇論文：Nachiappan M, Gurusinghe D, Bhandari S. Hypothermia in burns intensive care: use of the intravenous temperature management system Thermogard XP®. Critical Care. 2012;16(Suppl 2):A15. doi:10.1186/cc11273.

(D) 血液重新分配，腸胃血液減少，蠕動下降以致排空減緩，正確。

(E) 燒傷後人體會需要大量能量，血中 Glucagon 會上升使血糖增加。

【出處】08 共筆 Vol.3 P.8(非燒傷範圍)

題號	答案	詳解
9	C	(A)小孩較容易被燒燙傷。https://www.cbf.org.tw/ (B) 98% 也有救回來（老師經手案例有救回來，耗時 9 年，常常想自殺）。 (C) 因為 > 70% TBSA 的病患沒有足夠的皮膚，要微粒植皮，精簡使用。 (D) 以色列人，參考 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19211191。 (E) 見 (C)，> 70%。40 ~ 60% 一般自體植皮還可以負荷。 【出處】08 共筆未提
10	C	Parkland formula 適用於燒傷面積 > 30% TBSA 的病患。燒傷後頭 24 小時需要的液體量是 $\text{body weight (kg)} \times \text{TBSA (\%)} \times 4 \text{ ml/kg}$，一半在前 8 小時給予，一半在後 16 小時給予。 【出處】08 共筆 Vol.3 P.38
11	D	癒合時結締組織增生太多，非無法癒合；若在關節附近會造成關節僵硬。 【出處】08 共筆 Vol.3 P.31
12	A	Curreri formula = $25 \text{ kCal} \times \text{燒傷前體重 (kg)} + 40 \text{ kCal} \times \text{燒傷面積 burned BSA (\%)}$，$25 \times 70 + 40 \times 60 = 4150 \text{ (kcal)}$。 【出處】08 共筆 Vol.3 P.40
13	B	腸道還在工作就有細菌，若吸收不佳、營養不充足，腸壁可能變薄而有 bacterial translocation 危險。 【出處】08 共筆未提

四、多選題詳解

題號	答案	詳解
		燒傷病患需要住加護病房的標準為： 1. 10 歲以下小孩或 50 歲以上成人，2 度或 3 度燙傷 >10% TBSA。 2. 任何年紀，2 度或 3 度燙傷 > 20% TBSA。 3. 燒傷部位為：顏面、手掌、腳掌、會陰、主要關節。 4. 化學燒傷、電傷、吸入性灼傷。 5. 任何 2 度或 3 度燙傷併有創傷。 6. 燒傷加上其他疾病。
1	BDE	(A) 成人 10-50 歲，沒有大於 20% TBSA 所以免住。 (B) 小於 10 歲，有大於 10% TBSA，故要住。 (C) 只有 5% TBSA，不符合上述建議，故免住。 (D) 有顏面燒傷，要住。 (E) 手腳掌燒傷，住一下。 【出處】08 共筆 Vol.3 P.29,32
2	CD	(A) rule of 9:一隻腳的燒傷面積約為 18%，$18\% + 18\% = 36\%$ TBSA。 (B) 成人燒傷 > 30% TBSA 就要大量體液復甦。 (C) 要給予什麼液體目前沒有定論，傳統上是給予 lactated Ringer's，用 Parkland formula 計算量。成分相似的 Hartmann's solution 也有人使用。而 Colloid (albumin solution, dextran，老師表示要給但是要等燒傷後 6~8 小時再給) 與 hypertonic saline 使用有爭議。Fresh frozen plasma (FFP) 屬於一開始就可以補充的液體 (initial fluids)，本次上課未提，但查閱資料發現可用 West Penn Formula 計算，為 FFP $(75 \text{ ml/kg})/24 = \text{hourly rate for initial rate}$，過 48 hr 後視排尿量決定往上往下或維持此速率，例如排不出來就給更多。詳細內容請參考：https://evidencebasedpractice.osumc.edu/Documents/Guidelines/BurnCare.pdf。 (D) 大部份都是 IV 給予嗎啡類止痛藥，雖然 NSAID 止痛藥可口服，但不建議在嚴重燒傷使用。http://www.uptodate.com/contents/burn-pain-principles-of-pharmacologic-and-nonpharmacologic-management。 (E) 估計燒口癒合 > 14 天就要建議植皮。 【出處】08 共筆 Vol.3 P.29,32,34,35,38

題號	答案	詳解
3	CD	(B) 失敗的體液復甦會造成更多傷害 (C) Open method 是傷口不包紮，上塗抗生素藥劑等，暴露在溫暖的空氣底下，適用於臉部、會陰部。若是 14 天內會好的淺二度燒傷，放著不管也會自己癒合好起來。而根據外科手術傷口所學，此種方法會較快形成結痂，推測可抵抗感染不易惡化，但較痛且易散失體熱與水分。 (D) 屍皮與自身皮膚功能相似，能保有皮膚特性（調節溫度、防止水分喪失等），推測也能減緩傷口惡化。 【出處】08 共筆 Vol.3 P. 29,32,34,35,36,38
4	BCD	要去除發炎物質，然後給予保護。 (A) 沒後續保護。二度或以上的換藥步驟是：清瘡、塗殺菌藥膏、紗布包紮。 【出處】08 共筆 Vol.3 P.29,32,34,35,36

B03 第一次區段考

一、是非題

1-2	X	O
-----	---	---

二、單選題

1-10	B	A	D	B	D	C	D	A	D	A
11-20	E	E	B	C	B	C	C	A	C	C
21-28	A	D	B	A	B / D	C	B	C		

三、是非題詳解

題號	答案	詳解
1	X	面談的開始須以開放式問題，讓病人儘量表達。但掌握病人情況後，也會需要以直接性的問題，有助於做出鑑別診斷。
2	O	被證實與醫師遭投訴機率相關的因素包含：看診時間長短、是否提供足夠關於看診程序的說明、幽默感與微笑次數。

四、單選題詳解

題號	答案	詳解
1	B	對病患隱私絕對保密，也是專業素養的課題之一。 【出處】共筆 Vol.1 P.2
2	A	病史記載是要將「病人與家屬等所述」經過消化整理的。 【出處】共筆 Vol.1 P.13
3	D	(A) 順序是視診、聽診、觸診、扣診。 (B) 最痛的部位要最後檢查。 (C) 只有緊急的急診病人等，才可能有迅速做電腦斷層的必要。 【出處】共筆 Vol.1 P.18、Bates' Guide To Physical Examination And History Taking 12e P.470
4	B	Orthopnea 反映了肺水腫或 COPD，也可能來自於左心室的衰竭。 【出處】Bates' Guide To Physical Examination And History Taking 12e P.357

題號	答案	詳解
5	D	(A)(B) 沒有提及症狀持續時間。 (C) 老師上課表示沒有「chillness」這個單字。 【出處】共筆 Vol.1 P.26
6	C	應以主訴為中心鋪陳發展，選擇最為相關的敘述，故選(C)。 (A) 應記錄每天抽的量、持續抽幾年，或直接紀錄 pack-year。 (B) 缺少病患母親的紀錄。 (D) 應為「病患沒有已知的食物或藥物過敏」。 【出處】洪健清老師上課 ppt P.15
7	D	(D) 應為「Contact」。 【出處】共筆 Vol.1 P.30
8	A	整個左邊的 T4 dermatome 疼痛、感覺異常，問題可能來自於 T4 神經本身，例如 VZV 感染等。Acute MI 應表現胸痛（範圍大於 T4 單一 dermatome），可能延伸到左側頸部、手臂等處。 【出處】上課未提及
9	D	Nasopharynx、Tonsil、Tongue base、Piriform sinus 皆可能因腫瘤小找不到 primary origin。 另外注意：unknown primary site cancer 中的國外病人以 tonsillar cancer，而國內病人以 NPC（nasopharyngeal carcinoma）為主。 【出處】共筆 Vol.1 P.41
10	A	Branchial cleft cyst 位於 Level II。 另外雖然上課沒特別提到，但 thyroid cancer 除了在 level 6 以外，確實是有可能出現在 level 4 的。可參考這篇「pattern of nodal spread」段落。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4992997/ 【出處】共筆 Vol.1 P.51,52
11	E	(A)(B) 必做。(CBC：complete blood count) (C) 全麻或局麻需做。 (D) 四十五歲以上需開刀之患者需做。 (E) 肺功能檢查主要用於心肺手術的術前評估。 https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-preoperative-pulmonary-risk 【出處】上課未提及
12	E	(A)(B) 最為基本，因曾發生過 MI，手術導致心臟疾病的風險也較大，需做心臟超音波來評估；又因有抽菸習慣及易喘問題，最好做點肺功能的評估。

題號	答案	詳解																																																																																																																																																																																																																												
13	B	(B) Growth hormone 為 anabolic hormone。																																																																																																																																																																																																																												
14	C	傷口會造成內皮細胞、巨噬細胞、淋巴球、纖維母細胞等釋放發炎介質，促進傷口復原和修復。發炎介質包含：IL-1、IL-6、TNF。IL-16 主要為 T cell chemo-attractant，較無關。																																																																																																																																																																																																																												
15	B	(B) 心跳每分鐘 90 次以上。																																																																																																																																																																																																																												
16	C	(C) 期望病患能及早開始進食，有助於病患本身的術後復原。																																																																																																																																																																																																																												
17	C	傷口發生之後立刻活化血小板、凝血因子等開始止血，看傷口大小可能需要幾個小時。接下來活化的免疫系統會清除病原體；最後才是表皮細胞增生蓋住傷口，fibroblast 及 collagen 來做修復。																																																																																																																																																																																																																												
18	A	(A) 乾燥的環境會使創面上皮細胞增生停止。 (B) 合理。 (C)(D) 保持傷口濕潤度讓細胞別過乾而壞死、讓細胞移動、分裂加快，傷口癒合較快。																																																																																																																																																																																																																												
19	C	種類、部位、面積、深度為燙傷診斷四要素。																																																																																																																																																																																																																												
20	C	圖片為 Lund and Browder Chart。 <table><tr><th colspan="10">BURN ESTIMATE - AGE VS. AREA</th></tr><tr><th>Area</th><th>Birth-1 year</th><th>1-4 years</th><th>5-9 years</th><th>10-14 years</th><th>15 years</th><th>Adult</th><th>2°</th><th>3°</th><th>TBSA %</th></tr><tr><td>Head</td><td>19</td><td>17</td><td>13</td><td>11</td><td>9</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Neck</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ant. trunk</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Post. trunk</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R. buttock</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L. buttock</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Genitalia</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R.U. arm</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L.U. arm</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R.L. arm</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L.L. arm</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R. hand</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L. hand</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R. thigh</td><td>5.5</td><td>6.5</td><td>8</td><td>8.5</td><td>9</td><td>9.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L. thigh</td><td>5.5</td><td>6.5</td><td>8</td><td>8.5</td><td>9</td><td>9.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R. leg</td><td>5</td><td>5</td><td>5.5</td><td>6</td><td>6.5</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L. leg</td><td>5</td><td>5</td><td>5.5</td><td>6</td><td>6.5</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R. foot</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L. foot</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	BURN ESTIMATE - AGE VS. AREA										Area	Birth-1 year	1-4 years	5-9 years	10-14 years	15 years	Adult	2°	3°	TBSA %	Head	19	17	13	11	9	7				Neck	2	2	2	2	2	2				Ant. trunk	13	13	13	13	13	13				Post. trunk	13	13	13	13	13	13				R. buttock	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5				L. buttock	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5				Genitalia	1	1	1	1	1	1				R.U. arm	4	4	4	4	4	4				L.U. arm	4	4	4	4	4	4				R.L. arm	3	3	3	3	3	3				L.L. arm	3	3	3	3	3	3				R. hand	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5				L. hand	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5				R. thigh	5.5	6.5	8	8.5	9	9.5				L. thigh	5.5	6.5	8	8.5	9	9.5				R. leg	5	5	5.5	6	6.5	7				L. leg	5	5	5.5	6	6.5	7				R. foot	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5				L. foot	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5				TOTAL									
BURN ESTIMATE - AGE VS. AREA																																																																																																																																																																																																																														
Area	Birth-1 year	1-4 years	5-9 years	10-14 years	15 years	Adult	2°	3°	TBSA %																																																																																																																																																																																																																					
Head	19	17	13	11	9	7																																																																																																																																																																																																																								
Neck	2	2	2	2	2	2																																																																																																																																																																																																																								
Ant. trunk	13	13	13	13	13	13																																																																																																																																																																																																																								
Post. trunk	13	13	13	13	13	13																																																																																																																																																																																																																								
R. buttock	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5																																																																																																																																																																																																																								
L. buttock	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5																																																																																																																																																																																																																								
Genitalia	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																								
R.U. arm	4	4	4	4	4	4																																																																																																																																																																																																																								
L.U. arm	4	4	4	4	4	4																																																																																																																																																																																																																								
R.L. arm	3	3	3	3	3	3																																																																																																																																																																																																																								
L.L. arm	3	3	3	3	3	3																																																																																																																																																																																																																								
R. hand	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5																																																																																																																																																																																																																								
L. hand	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5																																																																																																																																																																																																																								
R. thigh	5.5	6.5	8	8.5	9	9.5																																																																																																																																																																																																																								
L. thigh	5.5	6.5	8	8.5	9	9.5																																																																																																																																																																																																																								
R. leg	5	5	5.5	6	6.5	7																																																																																																																																																																																																																								
L. leg	5	5	5.5	6	6.5	7																																																																																																																																																																																																																								
R. foot	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5																																																																																																																																																																																																																								
L. foot	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL																																																																																																																																																																																																																														
21	A	Parkland Formula： $4 \text{ mL/kg/\%} \times \text{體重 (kg)} \times \text{燒傷面積 (\%)}。$ 注意應給予 Lactated Ringer's solution，而非 normal saline。																																																																																																																																																																																																																												
22	D	大面積燒傷時會產生很多的 cytokine，像是 IL-1、IL-6、IL-8 和 TNF- α ，這些 cytokine 決定全身性的發炎反應。因此全身微血管滲透性都會增加，造成全身腫脹、低血壓、體液及電解質流失、滲透壓降低。																																																																																																																																																																																																																												
23	B	“Medicine is the uncertainty science and an art of probability.” —William Osler。																																																																																																																																																																																																																												

24	A	“To <i>cure sometimes</i> , to <i>relieve often</i> , to <i>comfort always</i> .” 為 Edward
25	B/D	Livingston Trudeau 的墓誌銘。
26	C	但是有一說 Hippocrates（古希臘醫者希波克拉底）曾說過 “To <i>cure sometimes</i> , to <i>treat often</i> , to <i>comfort always</i> .”
27	B	Hypoglycemia 才會造成 consciousness disturbance；hyperglycemia 本身並不會。
28	C	Cerebral artery 需擴張，以維持大腦正常的血流量。

B04 第一次區段考

一、是非題

1-2	X	O
-----	---	---

二、單選題

1-10	B	D	D	D	D	A	B	C	A	B
11-17	B	C	D	A	D	B	B			

三、是非題詳解

題號	答案	詳解
1	X	面談的開始應以開放式問題讓病人盡量表達。但掌握病人情況後，則需要以封閉式問題協助鑑別診斷。 【出處】共筆 Vol.1 P.50
2	O	被證實與醫師遭投訴機率相關的因素包含：看診時間長短、是否提供足夠關於看診程序的說明、幽默感與微笑次數。 【出處】共筆 Vol.1 P.53

四、單選題詳解

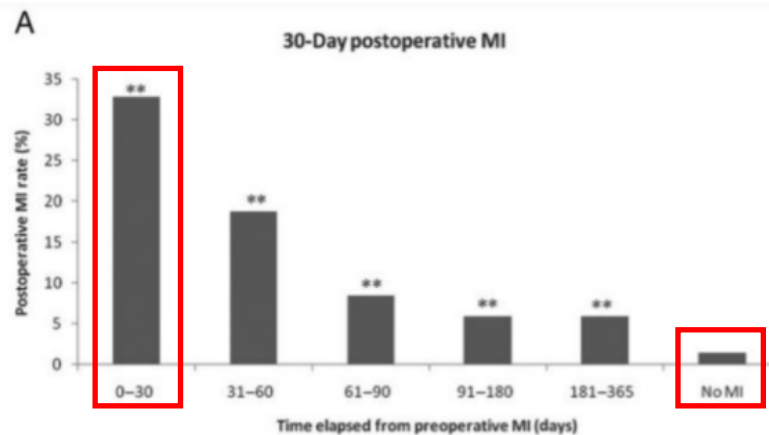
題號	答案	詳解																																				
		(B) 超音波的意思。																																				
1	B	檢查順序：先進行 inspection，後三者的順序則較不一定。 【出處】共筆 Vol.1 P.13																																				
2	D	<table><tr><th colspan="3">Characteristics</th><th>Examples</th></tr><tr><td>L</td><td>Location</td><td>位置、有無放射</td><td>右上腹痛且傳導至背後</td></tr><tr><td>Q</td><td>Quality</td><td>性質(像甚麼感覺)</td><td>持續悶痛</td></tr><tr><td>Q</td><td>Quantity (time course)</td><td>發作的量及強度</td><td>勉強可忍受</td></tr><tr><td>O</td><td>Onset mode</td><td>發作時間</td><td>晚飯後一小時突然開始</td></tr><tr><td>P</td><td>Precipitating factors</td><td>誘發因素</td><td>吃大餐</td></tr><tr><td>E</td><td>Exaggerating factors</td><td>加重因素</td><td>一吃東西就更痛</td></tr><tr><td>R</td><td>Relieving factors</td><td>緩解因素</td><td>空腹時稍好</td></tr><tr><td>A</td><td>Accompanying symptoms</td><td>相關表現</td><td>發燒、嘔吐</td></tr></table> 【出處】共筆 Vol.2 P.9	Characteristics			Examples	L	Location	位置、有無放射	右上腹痛且傳導至背後	Q	Quality	性質(像甚麼感覺)	持續悶痛	Q	Quantity (time course)	發作的量及強度	勉強可忍受	O	Onset mode	發作時間	晚飯後一小時突然開始	P	Precipitating factors	誘發因素	吃大餐	E	Exaggerating factors	加重因素	一吃東西就更痛	R	Relieving factors	緩解因素	空腹時稍好	A	Accompanying symptoms	相關表現	發燒、嘔吐
Characteristics			Examples																																			
L	Location	位置、有無放射	右上腹痛且傳導至背後																																			
Q	Quality	性質(像甚麼感覺)	持續悶痛																																			
Q	Quantity (time course)	發作的量及強度	勉強可忍受																																			
O	Onset mode	發作時間	晚飯後一小時突然開始																																			
P	Precipitating factors	誘發因素	吃大餐																																			
E	Exaggerating factors	加重因素	一吃東西就更痛																																			
R	Relieving factors	緩解因素	空腹時稍好																																			
A	Accompanying symptoms	相關表現	發燒、嘔吐																																			

題號	答案	詳解
3	D	(A) 應記錄症狀持續時間而非開始日期。另外年齡書寫錯誤。 (B) 應記錄症狀持續時間而非開始日期。 (C) 老師上課表示沒有「chillness」這個單字。 【出處】共筆 Vol.2 P.8
4	D	(D) 應為「Contact history」。 【出處】共筆 Vol.2 P.12
5	D	(A) 發生位置：75% 在 midline (B) 高度：65% 在 hyoid bone 下緣。 (C) 需連 hyoid body 一併切除以避免復發（Sistrunk's operation）。 (D) 跟 thyroid 有關的腫塊，通常吞嚥時都會上下移動。 (E) 正確，為胚胎學的範圍。 【出處】共筆 Vol.1 P.29
6	A	軟組織和顱底適合 MRI，硬骨組織適合 CT。 【出處】共筆 Vol.1 P.19,20
7	B	Pack year 的計算方式： 病人每天抽的數量（包）× 病人抽的時間（年）。例：1 pack year = 1PPD for 1 year; 2PPD for 0.5 years.....。 注意一包菸有 20 枝。 【出處】上課未提及。以上資料取自 https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/pack-year

題號 答案

詳解

(A) 術前 30 天發生 MI 者術後復發 MI 的機率 > 30%，無 MI 病史者術後發生 MI 的機率則 < 5%。



(B) 根據 Arozullah Risk Index，此病患年齡超過 70 歲 = 6 分；上腹部手術 = 14 分；BUN > 30 = 8 分；有 COPD 病史 = 6 分。加總為 34 分，屬於 Class 4，發生呼吸衰竭機率为 10.1%。Class 1 發生率才會小於 0.5%，考試若沒有附評分表可能要推測以他的健康狀況術後併發症的機率應該會更高。

Arozullah Respiratory Failure Risk Index

8

C

Type of Surgery	Point Value	Class	Point Total	Respiratory Failure %
• AAA	27	One	<= 10	0.5
• Thoracic	21	Two	11 - 19	1.8
• Neurosurgery, Upper Abdominal, Peripheral Vascular, Neck	14	Three	20 - 27	4.2
• Emergency Surgery	11	Four	28 - 40	10.1
• Albumin < 3.0 g/dL	9	Five	> 40	26.6
• BUN > 30 mg/dL	8	Low Risk Arozulla 1		
• Partial/Full Dependence	7	To OR		
• History of COPD	6	Intermediate Risk Arozulla 2 - 3		
• Age > 70	6	Consider Further Testing CXR, PFT if will change management		
• Age 60 - 69	5	High Risk Arozulla >= 4		
Arozullah AM, Daley J, et al, Ann Surg 2000; 232:242				Reconsider surgery Shorter Procedure Spinal or Epidural

(C) 六個月內有 MI、高齡、Cre > 2mg/dl、functional capacity < 4 MET 者，術後心臟疾病風險高；患 COPD 術後肺部疾病風險高。應延遲手術。

(D) 根據 ASA 評估表，Class I 為健康病人，據此病人狀況推測其應屬 ASA 第 3 級，可再評估延期手術之可能。

Classification of Operative Risk (American Society of Anesthesiologists)	
Normal healthy patient	0.01%
Patient with mild systemic disease	0.1%
Patient with severe disease that limits activity but is not incapacitating	1%
Patient with an incapacitating disease that is a constant threat to life	10%
Moribund patient not expected to survive 24 hours with or without surgery	50+%

【出處】共筆 Vol.2 P.17, 20, 21, 24, 25

題號	答案	詳解												
9	A	ASA 以病人手術前之健康狀況大致評估手術風險（可參考上題所附表格），本例病人健康，屬於風險最低之 Class I。 【出處】共筆 Vol.2 P.17												
10	B	(B) Growth hormone 為 anabolic hormone。 【出處】共筆 Vol.3 P.5												
11	B	(B) 心跳每分鐘 90 次以上。 【出處】共筆 Vol.3 P.5,8												
12	C	(C) 期望病患能及早開始進食，有助於病患本身的術後復原。 【出處】共筆 Vol.3 P.5												
13	D	若讓傷口過於濕潤，則有如浸泡在水中，會影響旁邊的健康組織。 應該讓傷口「有點濕又不會太濕」。 【出處】共筆 Vol.3 P.21												
14	A	今年上課只有提到(A)(D)，(A)最為泛用 (A) Simple interrupted suture 是撕裂傷（laceration）處理的 golden standard。 (B) Continuous(Running) suture 用於線性的長傷口 (C) Subcutaneous suture 用於較深的傷口 (D) Vertical suture 用於受張力或易內翻的傷口，可將傷口對齊 【出處】共筆 Vol.3 P.19、20 https://www.aafp.org/afp/2017/0515/p628.html												
15	D	<table><tr><th>急性傷口</th><th>慢性傷口</th></tr><tr><td>少量炎性細胞激素</td><td>大量炎性細胞激素</td></tr><tr><td>少量的蛋白質酵素（Matrix metalloproteinases, MMPs）</td><td>大量的蛋白質酵素（MMPs）</td></tr><tr><td>大量細胞有絲分裂</td><td>少量細胞有絲分裂</td></tr><tr><td>生長因子濃度高</td><td>生長因子濃度低</td></tr><tr><td>細胞反應快速</td><td>細胞反應緩慢，衰老細胞較多</td></tr></table> (A)(B)(C) high → low。 【出處】今年未提及，06 共筆 Vol.3 P.37	急性傷口	慢性傷口	少量炎性細胞激素	大量炎性細胞激素	少量的蛋白質酵素（Matrix metalloproteinases, MMPs）	大量的蛋白質酵素（MMPs）	大量細胞有絲分裂	少量細胞有絲分裂	生長因子濃度高	生長因子濃度低	細胞反應快速	細胞反應緩慢，衰老細胞較多
急性傷口	慢性傷口													
少量炎性細胞激素	大量炎性細胞激素													
少量的蛋白質酵素（Matrix metalloproteinases, MMPs）	大量的蛋白質酵素（MMPs）													
大量細胞有絲分裂	少量細胞有絲分裂													
生長因子濃度高	生長因子濃度低													
細胞反應快速	細胞反應緩慢，衰老細胞較多													

題號	答案	詳解
16	B	判斷吸入性燒傷的幾個線索：鼻毛燒到、口有炭渣、聲音沙啞、Trachea < 0.7 cm、起火點在地下室。根據網路資料顯示，其實四個選項都是吸入性燒傷的特徵。資料來源如下： https://www.uptodate.com/contents/inhalation-injury-from-heat-smoke-or-chemical-irritants http://www.disaster.org.tw/skh_meet/lecture101/10104/Special1010409.pdf 事實上大五共筆也有該老師的考題，答案給的是 B。推測老師應該是希望我們選跟上呼吸道最相關的症狀，故此處答案同樣也給 B。 【出處】上課未提及。
17	B	燒傷的 Rule of "nines"：成人單側下肢 18%；單側上肢 9%。 【出處】共筆 Vol.3 P.32

B05 第一次區段考

一、單選題

1-10	A	B	D	C	C	B	A	D	C	A
11-18	B	C	B	C	B	A	C	B		

二、單選題詳解

題號	答案	詳解
1	A	制度下的工作（system-based practice）指的是因應醫療照護的制度，有效使用相關資源，以提供合適的照顧。醫學四的實習醫學生尚未學習插導尿管的技術，不應在沒有監督的情況下擅自進行。 【出處】共筆 Vol.1 P.3
2	B	病史記載是要將「病人與家屬等所述」經過消化整理的。 【出處】共筆 Vol.2 P.9 或用常識判斷
3	D	(A) 在腹部，為避免觸診、扣診導致腸胃活動改變，因此順序改為視診、聽診、觸診、扣診。 (B) 應由健康的部位開始，逐漸移向病變區域。 (C) 高科技診察耗時燒錢，不如身體診察有效率。 (D) Gland function ↓ → cortisol、aldosterone ↓ → hypotension (hyponatremic volume contraction)、hyperkalemia、metabolic acidosis、skin / mucosal hyperpigmentation (melanin synthesis ↑ due to MSH ↑, a byproduct of ACTH production by POMC)。(資料來源：FA2020 P.349) 【出處】共筆 Vol.1 P.41、Bates' Guide To Physical Examination And History Taking 12e P.470
4	C	甲狀腺功能低下的症狀包含疲倦、怕冷、便秘、體重增加、皮膚乾燥、頭髮變少、經期不穩等等。 手抖、緊張應為甲狀腺功能亢進的表現。 【出處】上課未提及，依據解剖生理知識判斷（Guyton 13e P.962）
5	C	(A) 年齡書寫錯誤。 (B) 應記錄症狀持續時間而非開始日期。 (D) 應記錄症狀持續時間而非開始日期。 【出處】共筆 Vol.2 P.8
6	B	(B) O 應為「Occupation」。 【出處】共筆 Vol.2 P.8
7	A	頭頸部惡性淋巴瘤不論是 Hodgkin's lymphoma 或是 Non-Hodgkin's lymphoma，都以側頸部腫塊為主要症狀。

題號 答案

詳解

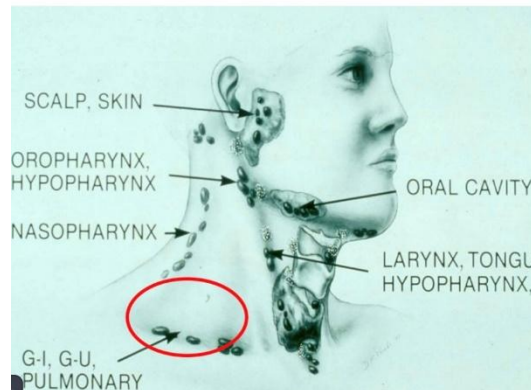
次要症狀包含 diffused lymphadenopathy、hepatosplenomegaly、fever。

Fine needle aspiration cytology (FNAC) 無法診斷 lymphoma。

【出處】共筆 Vol.1 P.26

Location, location, and location!

8 D



Lymph nodes:
reactive, lymphoma,

TB

Lymphangioma

Kikuchi's disease

【出處】共筆 Vol.1 P.24

9 C

病態肥胖 (BMI > 40) 應要考慮以減重手術治療。關於肥胖治療的 guideline 可參考這篇：Wharton et al. (2020). **Obesity in adults: a clinical practice guideline.** *CMAJ* August 04, 2020 192 (31) E875-E891; DOI: <https://doi.org/10.1503/cmaj.191707>

【出處】今年未提及。

10 A

最常見的為 gastric bypass surgery。

Restrictive 為減少胃的容量，malabsorptive 為減少腸胃道吸收；gastric bypass 兩者都有。Gastric balloon 則是在胃中放入氣囊，單純減少容量而不影響腸胃道的吸收。

Sleeve gastrectomy 常見的副作用有胃食道逆流、噁心、胃痛等。

【出處】今年未提及，參考網路資料。

11 B

(B) Growth hormone 主要促進合成，為 anabolic hormone。

【出處】共筆 Vol.3 P.7

12 C

傷口會造成內皮細胞、巨噬細胞、淋巴球、纖維母細胞等釋放發炎介質，促進傷口復原和修復。發炎介質包含：IL-1、IL-6、TNF。IL-16 主要為 T cell chemo-attractant，較無關。

【出處】共筆 Vol.3 P.8

13 B

(B) 心跳每分鐘 90 次以上。

【出處】共筆 Vol.3 P.8

題號 答案

詳解

- 14 C Remodeling phase 以 epithelial cell 覆蓋傷口、myofibroblast 或 fibroblast 增生形成 scar 為主要內容。

【出處】共筆 Vol.3 P.15, 16

15	B	急性傷口	慢性傷口
		少量炎性細胞激素	大量炎性細胞激素
		少量的蛋白質酵素 (Matrix metalloproteinases, MMPs)	大量的蛋白質酵素 (MMPs)
		大量細胞有絲分裂	少量細胞有絲分裂
		生長因子濃度高	生長因子濃度低
		細胞反應快速	細胞反應緩慢，衰老細胞較多

(B) Low → high。

【出處】今年未提及。

- 16 A 傷口要保持滋潤而非乾燥。

【出處】共筆 Vol.3 P.21

ABSI score (Abbreviated Burn Severity Score) :

1. 性別 Sex
2. 年齡 Age。
3. 有無吸入性灼傷。
4. 是否有 full-thickness burn：達三度燒傷。
5. 燒傷面積 TBSA。

Table 1 Tobiasen's abbreviated burn severity index score (ABSI) [6]

Parameter	Finding	Points	Parameter	Finding	Points
Sex	Female	1	TBSA (%)	1-10	1
	Male	0		11-20	2
Age (years)	0-20	1		21-30	3
	21-40	2		31-40	4
	41-60	3		41-50	5
	61-80	4		51-60	6
	81-100	5		61-70	7
Inhalation injury	Yes	1		71-80	8
	No	0		81-90	9
Full thickness burn	Yes	1		91-100	10
	No	0			

- 17 C

現在多改用 Modified Baux

score，考慮燒傷面積、年齡、是否有吸入性灼傷。若病患超過 60 歲、TBSA 超過 60% 且有吸入性灼傷，死亡率高達 95%。(注意燒傷深度沒有列在考慮範圍內)

【出處】今年未提及。共筆 Vol.3 P.40

參照 04 第 16 題。

- 18 B 判斷吸入性燒傷的幾個線索：鼻毛燒到、口有炭渣、聲音沙啞、Trachea < 0.7 cm、起火點在地下室（密閉空間）。

推測老師應該是希望我們選上呼吸道相關的症狀，故答案給 B。

【出處】今年未提及。

B06 第一次區段考

一、單選題詳解

題號	答案	詳解
1	A	(B) 應打開燈（床頭、天花板） (C) 應坐好與患者視線等高或稍低 (D) 未提及 【出處】共筆 Vol.1 P.34
2	X	(B) 主訴的寫法 【出處】共筆 Vol.2 P.8
3	D	(D) LQQOPERA 中的程度（Quantity）：症狀的強度，有多痛？可用以下三種表示法： (a) Pain Scale：0-10 分 (b) 表情：Wong-Baker faces pain rating scale (c) 影響日常活動程度 【出處】共筆 Vol.1 P.35
4	X	題目缺失
5	C	原題目缺失，應是問病歷書寫的排序，注意 present illness 要寫在 past history 前。 【出處】共筆 Vol.2 P.5
6	D	(A)(B) 應該寫來到醫院前「幾天」的時間 要注意這題有個選項出現 chillness，英文裡沒有 chillness 這個字（google 查得到，但是 Cambridge dictionary 未收錄） 【出處】共筆 Vol.2 P.8
7	C	主訴後應以主訴為中心鋪陳發展，選擇最為相關的敘述。 (A) 缺少心肌梗塞發生時間與吸菸量及時長 (B) 缺少病患母親的紀錄。 (C) 與主訴最為相關。 (D) 應補充在(C)之後 【出處】共筆 Vol.2 P.9
8	X	(A) 目前使用的藥物（current medication）和活動性（active）疾病也要記錄。 【出處】共筆 Vol.2 P.11
9	B	(B) 常位於 posterior triangle nodes（level V），SCM 後方。 【出處】共筆 Vol.1 P.24
10	A	(A) 共筆沒寫但投影片有提到為罕見腫瘤，亦可在相關論文查到 Carotid body tumors (CBTs), which are also termed chemodectomas, are rare neoplasms with a reported incidence of one in 30,000. (B)(C) 正確，不做切片、FNAc 避免噴泉 (D) 病人很老，考慮放射治療或密集追蹤 【出處】共筆 Vol.1 P.26

題號	答案	詳解												
11	E	Remodeling phase 以 epithelial cell 覆蓋傷口、myofibroblast 或 fibroblast 增生形成 scar 為主要內容。 【出處】共筆 Vol.2 P.33,34												
(E) 應為 Low growth factor production，參考下表														
12	E	<table><tr><th>急性傷口</th><th>慢性傷口</th></tr><tr><td>少量炎性細胞激素</td><td>大量炎性細胞激素</td></tr><tr><td>少量的蛋白質酵素（Matrix metalloproteinases, MMPs）</td><td>大量的蛋白質酵素（MMPs）</td></tr><tr><td>大量細胞有絲分裂</td><td>少量細胞有絲分裂</td></tr><tr><td>生長因子濃度高</td><td>生長因子濃度低</td></tr><tr><td>細胞反應快速</td><td>細胞反應緩慢，衰老細胞較多</td></tr></table>	急性傷口	慢性傷口	少量炎性細胞激素	大量炎性細胞激素	少量的蛋白質酵素（Matrix metalloproteinases, MMPs）	大量的蛋白質酵素（MMPs）	大量細胞有絲分裂	少量細胞有絲分裂	生長因子濃度高	生長因子濃度低	細胞反應快速	細胞反應緩慢，衰老細胞較多
		急性傷口	慢性傷口											
		少量炎性細胞激素	大量炎性細胞激素											
		少量的蛋白質酵素（Matrix metalloproteinases, MMPs）	大量的蛋白質酵素（MMPs）											
		大量細胞有絲分裂	少量細胞有絲分裂											
		生長因子濃度高	生長因子濃度低											
細胞反應快速	細胞反應緩慢，衰老細胞較多													
僅在 07 共筆 Vol 2 P33 提到急性與慢性傷口的差別在慢性傷口停留在 inflammation 的階段，無法進到 remodeling phase。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.33														
13	C	(A) 乾燥環境下細胞無法生長，且傷口創面滲出液含生長因子可幫助傷口癒合。												
		(B) 若傷口乾淨則無需額外用優碘、抗生素消毒，其無助於癒合且增加抗藥性細菌產生的風險。												
		(D)對於乾淨的傷口，病人手術 48 小時後即可稍微碰水（例如沖澡），碰不碰水對預後是沒有差異的。												
		(E) 紗布是為了讓創面乾燥的一種素材，創面若保持乾燥，則創面上皮增生停止，且乾燥後紗布固著在創面上，更換時會產生很大的疼痛並讓傷口再度出血，破壞創面。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.39												
		(C) 未提及，單純檢查沒有療效 (E) 是一種處置，但可行性不高 【出處】今年未提及糖尿病潰瘍												
14	C													
15	B	(B) Growth hormone 主要促進合成，屬於 anabolic hormone，其他於 catabolic hormone 【出處】07 共筆 Vol.2 P.12												
16	C	(C) 其餘三者均與急性發炎反應相關，IL-16 主要為 T cell chemo-attractant，較無關 【出處】07 共筆 Vol.2 P.12												
17	B	(B) 定義為心跳> 90/min。後文有詳述，有興趣者可閱讀原始文獻： https://doi.org/10.1378/chest.101.6.1644 【出處】07 共筆 Vol.2 P.12												
18	C	除非是切腸切胃的患者，否則宜盡早令病患自然進食，可加速復原 【出處】07 共筆 Vol.2 P.12												
19	D	(A) 健康病人為 ASA class I												

題號 答案

詳解

(B) 使用 insulin 至少應+1

Revised Cardiac Risk Index for Pre-Operative Risk (RCRI) 2019 Estimates risk of cardiac complications after noncardiac surgery
A considerable number of elderly had postoperative MACE, even if they (3.9%) were in the RCRI = 0 subgroup. J Geriatr Cardiol. 2018 Mar; 15(3): 215-221

RCRI Score	Risk of major cardiac event (95% CI)*
0	3.9% (2.8-5.4%)
1	6.0% (4.9-7.4%)
2	10.1% (8.1-12.6%)
≥3	15% (11.1-20.0%)

➤ 1), **High-risk surgery**: Intraperitoneal; intrathoracic; supra-inguinal vascular
 ➤ 2), **History of ischemic heart disease**: History of myocardial infarction (MI); history of positive exercise test; current chest pain considered due to myocardial ischemia; use of nitrate therapy or ECG with pathological Q waves
 ➤ 3), **History of congestive heart failure**: Pulmonary edema, bilateral rales or S3 gallop; paroxysmal nocturnal dyspnea; chest x-ray (CXR) showing pulmonary vascular redistribution
 ➤ 4), **History of cerebrovascular disease**: Prior transient ischemic attack (TIA) or stroke
 ➤ 5), **Pre-operative treatment with insulin**
 ➤ 6), **Pre-operative creatinine >2 mg/dL** ~eGFR<40

(C) RCRI score 0 仍有 3.9%風險 (2.8%-5.4%)

(D) 正確。Noncardiac surgery 最好在：

(a) 血管擴張術 (balloon angioplasty) 14 天以後。

(b) 血管支架 (BMS) 一個月以後。

(c) 塗藥支架 (DES) 一年以後。

【出處】共筆 Vol.2 P.19, 22

20 D

應將手術 delayed 1 to 3 months

【出處】07 共筆 Vol.2 P.20, 22

21 C

如何評估一位大面積燒傷病患的嚴重程度？

Baux score：燒傷面積 + 年齡

Modified Baux score：燒傷面積 + 年齡 + 17 (如果有吸入性燒傷)

LD50 (致死率超過 50%)：modified Baux score of 130-140。

(C) 種類未包含在內

【出處】07 共筆 Vol.2 P.56

22 B

參考 05 共筆老師的說法判斷吸入性燒傷的幾個線索：鼻毛燒到、口鼻炭渣、聲音沙啞、Trachea < 0.7 cm、起火點在地下室。

網路資料：有密閉環境燃爆或火焰燒傷史、並有口鼻周圍深度燒傷、鼻毛燒焦、聲音嘶啞、咽喉疼痛或困難、刺激性咳嗽、痰中含碳粒、肺部聽診早期出現喘鳴音等臨床表現時，應注意吸入性損傷。雖網路資料中選項皆為診斷依據，但參考往年答案以上呼吸道相關症狀為主，故選(B)。

【出處】今年未提及。05 共筆。A+醫學百科、另可參考 UpToDate <https://www.uptodate.com/contents/inhalation-injury-from-heat-smoke-or-chemical-irritants>

二、簡答題詳解

本處擷取共筆段落，可在看完病史詢問與身體診察及面談溝通技巧部分後整理出自己的答案

1. 用心準備（在看病人之前花點時間準備，穿著打扮合宜整潔，集中精力不想其他事）
2. 專心且完整地傾聽，讓病人主動陳述（前傾，側坐採 **open angle (90-120 度)**，以開放式問題開頭並避免中斷病人說話，手機收好）
3. 在最重要的問題上達成共識（找出患者關心的內容並將這些事項優先納入問診）
4. 與患者的故事保持連結，給予適當情緒支持，並適時整理、確認病患語意（考慮影響患者健康的生活環境；認可積極的努力；慶祝成功達到治療里程碑）
5. 探索情緒暗示（感知，提問並驗證患者的情緒、不過度引導）
6. 結束時進行總結，充分告知診斷及治療計畫，並詢問是否有遺漏重要訊息及其他問題

【出處】共筆 Vol.1 P.47-53

B07 第一次區段考

一、選擇題

1-10	C	D	C	A	B	D	C	A	B	E
11-20	B	C	D	C	B	C	B	C	D	D
21-22	C	B								

二、選擇題詳解

題號	答案	詳解
1	C	【出處】共筆 Vol.2 P.5
2	D	(A) (B) 主訴應用「症狀產生到入院的持續時間」表示，而非開始時間點。 (C) 陷阱！英文無 chillness 一詞，應使用 chill 。 【出處】共筆 Vol.2 P.8
3	C	(A) 沒有提及症狀發生時間、病因等資訊。 (B) 家族史應包含：成員年齡、病程等資訊。 (D) 此選項敘述跟現病史相關，因此應該歸類在 (C)。 【出處】共筆 Vol.1 P.35,36,37
4	A	過去病史主要是記載與主訴無關的慢性疾病，因此 (C)(D) 正確，而 (A) 錯誤，仍患有的慢性疾病依然可以記載在 past history 。 不太確定為何 (B) 是正確的，因為食物或藥物的過敏史應該是放在藥物史當中，但答案給 (A)。 【出處】共筆 Vol.1 P.36,37
5	B	(B) 有點訓話的語氣，而且提到性生活時用字遣詞應更加委婉，另外，應以「您」稱呼病人較為禮貌。 【出處】共筆 Vol.1 面談溝通技巧
6	D	身體診察包括視診 (inspection)、聽診 (auscultation)、聽診 (palpation)、扣診 (percussion)。 【出處】共筆 Vol.1 P.40
7	C	熟記 LQQOPERA 的內容，其中病人提到「因呼吸困難無法下床上廁所」，即描述呼吸困難的程度到會影響日常活動，屬於 Quantity 。 【出處】共筆 Vol.1 P.36,37
8	A	(A) 因表格遺失，所以無法確定，因為可能有陽性似然比算出來小於 1 的可能，但依常理推斷，手冊中出現此些症狀的診察資料，應能幫助診斷貧血，另外也可參考上課內容的表格。 (B) 除非其 specificity 為 100%，但常理推斷不可能。 (C) 即看 sensitivity ，其中結膜邊緣蒼白最小，因此機率應為最低。 (D) 是否更能診斷貧血要看三者的陽性似然比，陽性似然比為 (sensitivity/1-specificity)，手掌蒼白的 sensitivity 與 specificity 都比指甲床蒼白高，因此其陽性似然比也會較高（分子大且分母小），因此手掌蒼白應比指甲床蒼白更能診斷貧血。 【出處】共筆 Vol.1 P.43

題號	答案	詳解
9	B	P16 positive 可能跟 HPV 感染引起之口咽癌相關，其中最常見的就是扁條腺癌。 【出處】共筆 Vol.1 P.22
10	E	Lymphangioma 多在 Level 4 【出處】共筆 Vol.1 P.32、33
11	B	傷口癒合的分類： 1. Primary healing：傷口狹窄整齊，直接縫合可處理。 2. Delayed primary healing：較不乾淨的傷口，人咬傷屬於這種。 3. Secondary healing：Healing by wound contraction and epithelization，會形成 granulation tissue，容易有 scar。 4. Healing of partial-thickness wounds：部分 dermis 仍保留著，healing by re-epithelialization，擦傷、淺層燒傷這類的淺層傷口，healing 效果較 secondary healing 來得好。 【出處】共筆 Vol.3 P.16-18
12	C	Remodeling phase 以 epithelial cell 覆蓋傷口、myofibroblast 或 fibroblast 增生形成 scar 為主要內容。 【出處】共筆 Vol.3 P.15
13	D	07 共筆沒有，參考 https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2008/0701/p71.html No infection：完全沒膿、發言、紅腫 Mild：少許膿，輕微發炎侷限在 subcutaneous tissue 以上，沒有 systemic illness Moderate：發炎更嚴重（蜂窩性組織炎大於傷口邊緣 2cm、deep tissue abscess...）但病人整體生理狀態正常 Severe：發炎產生 systemic toxicity、metabolic instability（發燒、畏寒、tachycardia、hypotension...）
14	C	Yellow 為清創感染期，外觀上所見之黃色腐肉為發炎期細胞死亡累積的分泌物。 1. 鬆散濕軟的黃色黏稠壞死組織：暗示皮下脂肪死亡。 2. 乾硬頑強的黃色壞死組織：暗示肌肉組織被破壞。 【出處】共筆 Vol.3 P.23
15	B	受傷後身體能量需求增加，需要增加血糖等物質，所以 (A) Cortisol、(C) Glucagon、(D) Catecholamine 增加。 【出處】共筆 Vol.3 P.7
16	C	傷口會造成內皮細胞、巨噬細胞、淋巴球、纖維母細胞等釋放發炎介質，促進傷口復原和修復。發炎介質包含：IL-1、IL-6、TNF。IL-16 主要為 T cell chemo-attractant，較無關。 【出處】共筆 Vol.3 P.8
17	B	(B) 心跳每分鐘 90 次以上。 【出處】共筆 Vol.3 P.8
題號	答案	詳解

18	C	(C) 期望病患能及早開始進食，有助於病患本身的術後復原。 【出處】共筆 Vol.3 P.9
19	D	(D) 術前 creatinine 濃度 > 2mg/dL (腎功能) 【出處】共筆 Vol.2 P.19
20	D	血管相關的手術最容易產生 stroke，接著為心、胸、神經相關的手術，而一般外科的手術也會有。 【出處】共筆 Vol.2 P.22
21	C	(C) Fluid resuscitation 時應使用 lactated Ringer's solution 【出處】共筆 Vol.3 P.38
22	B	(B) 須讓小便維持在每小時 100 c.c. 以上 【出處】共筆 Vol.3 P.37

B08 第一次區段考

一、選擇題

1-10	C	B	C	C	E	D	C	C	D	E
11-12	C	全								

二、選擇題詳解

題號	答案	詳解
1	C	(C) 期望病患能及早開始進食，有助於病患本身的術後復原。 【出處】08 共筆 Vol.3 P.9
2	B	(B) 心跳每分鐘 90 次以上。 【出處】08 共筆 Vol.3 P.8
3	C	(C) 淺二度燒傷呈現單一粉紅色，通常會在 2 周內自行癒合，不需要特別介入治療。 (A)(B)(D) 要 21 天以上才會自行痊癒。 【出處】08 共筆 Vol.3 P.30
4	C	(A) 以開放式問題確認主訴，再用封閉性問題確認情況。 (B) 寫主訴時要盡量按照病人口說的描述記錄，而不是使用醫學專有名詞。 (C) 有多個症狀時選最早的症狀當主訴。 (D) 詢問過程不用按照病歷上主訴、現在病史、過去病史…的順序進行。 (E) 詢問過程錄音必須經過病人同意。 【出處】共筆 Vol.2 P.4, 6, 9, 10
5	E	(E) 用鐘面聽診需輕放不要用力壓，避免皮膚張緊而濾掉低頻。 【出處】共筆 Vol.2 P.11, (共筆沒寫但在) 上課投影片 P.26
6	D	(A)(B) 應該寫持續時間。 (C) 年紀的標準寫法為 XX-year-old。 【出處】共筆 Vol.1 P.39
7	C	IL-1、IL-6、TNF 皆與 acute inflammation 相關（作用在內皮細胞使之表現 adhesion molecule，並引發發燒、低血壓等症狀）。IL-16 主要為 CD4+ cells 的 chemoattractant，可以活化 T cell。 【出處】08 共筆 Vol.3 P.5

8	C	【出處】共筆 Vol.1 P.36
9	D	(D) 術前 creatinine 濃度 > 2mg/dL (腎功能) 【出處】08 共筆 Vol.2 P.19
10	E	(E) Dermoid Cyst 【出處】08 共筆 Vol.1 P.31
11	C	(C) 期望病患能及早開始進食，有助於病患本身的術後復原。 【出處】08 共筆 Vol.3 P.9
12	全	(A) 沒錯！ (B) 沒錯！ (C) 沒錯！ (D) 貧血會造成 ESR (紅血球沉降速率: erythrocyte sedimentation rate) 上升。 (E) ESR 是一種間接測量慢性發炎的方法(可用於診斷自體免疫疾病)； CRP 用於觀察急性的全身性發炎，但詳細適用區間不明。 【出處】08 病理共筆 Vol.2 P59 (08 臨醫共筆未提)

三、是非題

1	O
---	---

1	O	正確
---	---	----

B09 第一次區段考

一、選擇題

1-10	A	A	D	C	A	A	D	A	D	C
11-20	B	B	B	D	C	B	C	B	B	C

二、選擇題詳解

題號 答案

詳解

1

A

(A) (B) (D) Lymphoma 之次要症狀包含發燒、肝脾腫大及全身淋巴腫大，然而相當少見，成年人大多僅呈現側頸部腫塊。

(C) FNAC 不容易診斷 Lymphoma，即使呈現陰性也要做 open biopsy 或者至少 CNB，還有一系列 full workup 包含 CT scans、bone marrow biopsy 及 PET。

【出處】09 共筆 Vol. 1 P.26

2

A

(A) (B) (D) 神經性腫瘤包含 schwannoma、neurofibroma 及 malignant peripheral nerve sheath tumor，其中在頭頸部最常見的是 schwannoma。

(C) Neuroblastoma 課堂中未提及，簡介如下：

Neuroblastoma 為兒童癌症中常見的固態惡性腫瘤，源於交感神經系統中 neural crest cell 造成的惡性增殖，好發於交感神經系統分佈範圍如後腹腔及腎上腺，頭頸、胸部及骨盆腔亦有病例發現。可參考：

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448111/>

【出處】09 共筆 Vol. 1 P.27

3

D

病例書寫順序為 Chief complaint, Present illness, Past history，其中 Review of System 是 Present illness 的一部分，如果"有"就移到 Present illness 中，寫在適當病史發生的時間，而非停留放在個別的項目中。

【出處】09 共筆 Vol.1 p.38, p.44(病歷書寫 課程 ppt p.20)

4

C

(A) 先用開放式問題了解病情，再用封閉式問題確認症狀。

(B) 這樣做其實等同醫生在給患者提供更多的症狀，而不是讓患者自己描述病史。

(D) 引導性問題將引導患者回答特定答案。

(E) 同時問幾個問題，可能會令病人困惑，常常只回答最後一個問題。

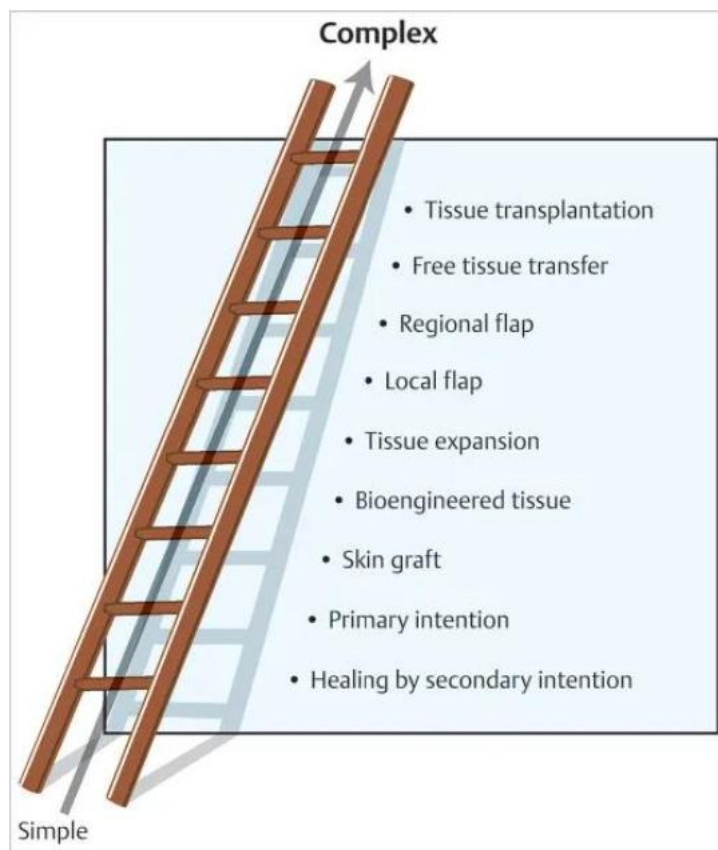
【出處】09 共筆 Vol.2 p.4-5

5	A	老師上課有提到 pain scale 為問診之工具，可以詢問病人 0-10 分有幾分痛。而(B)(C)(D)與疼痛無直接關聯。 【出處】B09 共筆 Vol.2 p.6
6	A	叩診聲音:resonance(胸)、dullness(心肝脾)、tympany(腹)、flatness(腿) 【出處】B09 共筆 Vol.2 p.11
7	D	手術前評估包含 Surgical procedure (B 選項)、Elective or emergent、Medical history(A 選項，C 選項用藥史應該也涵蓋在裡面)、Physical examination、Lab tests and image studies、Psychiatric evaluation 【出處】B09 共筆 Vol.3 p.5
8	A	根據 ASA 評估表，分為五等級 Class I: 身體狀況正常病人，手術風險 0.01% Class II:有輕微系統性疾病的病人 (糖尿病、高血壓等等)，手術風險為 0.1% Class III:嚴重疾病使病人活動力受限但不至於造成失能，手術風險是 1% Class IV:失能且有對生命造成威脅的疾病，手術風險是 10% Class V: 若不馬上處理，病患很可能無法活過 24 小時小時，常在急診出現，例如大失血，手術風險高於 50% 以上所寫的手術風險只是預估，那根據這個表，平常健康沒有慢性病且愛跑步的 20 歲男性，大概就是 Class I 【出處】B09 共筆 Vol.3 p.6
9	D	如果這個年輕人在海灘玩時曬傷，並且曬傷是表面的（如第一度或輕度的曬傷），那麼他遵守的是 healing of partial-thickness wounds （部分厚度傷口癒合）。這類傷口一般涉及表皮和部分真皮層組織，不須經由傷口的縫合，也不須經由 wound contraction，直接由旁邊表皮細胞 re-epithelialization 即可癒合。 【出處】B09 共筆 Vol.3 p.29
10	C	在傷口顏色分類系統中，外觀上有黃色腐肉為發炎期細胞死亡累積的分泌物，包含皮下脂肪死亡(鬆散濕軟)及肌肉組織被破壞(乾硬)，而不是脂

肪組織。所以黃色是 sloughy/ eschar 清創感染期。脂肪組織通常呈現淡黃色或白色，但在傷口分類系統中，黃色指的是需要清除的壞死組織。

【出處】B09 共筆 Vol.3 p.34

- 11 B **Reconstructive ladder** 為外科醫師要重建傷口時的處理原則，由最底層簡單的情況開始，無法補起來就往上一階走(見下圖)。在上課時老師介紹了 skin graft (從病人身上其他區域移植皮膚到傷口，要移植的皮膚會被弄的像網子一樣覆蓋在傷口上，目的是為了更大範圍的覆蓋傷口，如右下圖)、tissue expander (可促使健康組織長出額外的新組織，再拿來重建傷口，上課舉的例子為患者在頭皮下打一顆水球)、rotation flap (在傷口附近的完好皮膚劃出弧形切口，將皮瓣拉往傷口處並縫合)、free tissue transfer (將組織連同供應它的血管一起取下，移至傷口處，並將血管接好，老師提及的案例是取大網膜移至受傷到見骨的頭頂，並搭配植皮予以重建)的臨床案例。



【出處】B09 共筆 Vol.3 p.36

- 12 B Dermis 的厚度為 1-4 mm、平均 2 mm，是皮膚最重要的一層。

【出處】B09 共筆 Vol.3 p.38

- 13 B 大面積深度燒燙傷後，皮膚受損，致水分、電解質、albumin 等無法保留在循環系統內；死亡的細胞及組織亦會放出大量 cytokines (IL-1、IL-

6、IL-8、TNF- α) 造成全身性的發炎反應 (SIRS)，造成病患低血壓、周邊循環不良、休克等等，故稱 burn shock。

為了避免低血壓及 hemoglobin 造成 acute tubular necrosis、並且穩定血液動力學、幫助腎臟排泄毒素等等，必須積極地給予病患 lactated Ringer's solution。

【出處】B09 Vol.3 p.37-54

- 14 D 因發生全身性發炎反應，燒燙傷部位內皮細胞亦可能受損，故血管通透性增加，詳細請見上題詳解。

【出處】B09 Vol.3 p.37-54

- 15 C 適當的傷口處置，包含：使用合適的敷料，及時的焦痂切開手術、燒傷清創手術、以及重建手術。故(C)冰敷和按摩不正確。

【出處】B09 Vol.3 p.37

- 16 B 手術本身就是一種傷害；而對於傷害，身體會產生 Neuro-humoral Response：catabolic hormone 增加，anabolic hormone 降低。其中，僅 Growth Hormone 為 anabolic hormone，故選(B)。

- 17 C 身體受傷後，IL-1,IL-6,IL-8 和 TNF- α 皆與急性發炎反應有關，IL-16 主要和 T-cell 的 chemo-attractant 有關，和急性發炎症狀無關

【出處】B09 Vol.3 p.58

- 18 B Catebolic hormone 主要功能是促進大分子分解變成小分子，以產生能量或是提供原料給合成作用。如 Cortisol 就是促進 gluconeogenesis, lipolysis。Glucagon 就是促進 glyconeolysis。Catecholamine 也和促進 lipolysis 等作用有關。而 Growth hormone 主要功能和增加 protein synthesis 有關，屬於 Anabolic hormone。

【出處】B09 Vol.3 p.57

- 19 B SIRS 需符合下列四項標準之兩項或以上者：

體溫：>38°C或<36°C

心跳：>90 次/分

呼吸速率：>20 次/分或 PaCO₂<32mmHg

白血球計數：>12000 cells/mm³, <4000 cells/mm³

<https://www.mohw.gov.tw/dl-66174-ff4e5da2-ddc5-4f07-9f37-67434e5a1177.html>

【出處】 B09 Vol.3 p.55

20 C 除非是切腸切胃的患者，否則宜盡早令病患自然進食，可加速復原。

【出處】 B09 Vol.3 p.55

三、問答題

-
- 1 (A) 「是什麼樣的原因讓你這樣問」
 (B) 以問代答，了解病人背後真實的狀態(病人的想法)與情緒因素，可以再進一步對於一些症狀、病徵適度回應。

【出處】 B09 Vol.2 p.17

B10 第一次區段考

一、選擇題

1-10	B	D	A	D	B	B	C	D	C	B
11-20	C	B	B	C	B	C	B	C	D	C
21-22	B	D								

二、選擇題詳解

題號 答案

詳解

1	B	(E) 提高醫生診斷能力：結果上會提高診斷力，但本質上目的是收集資訊。
2	D	蒐集病史時，最重要的並不是一次把所有症狀都處理完，而是要先釐清病人主要的、最困擾或最影響病程的症狀，並進一步了解它的屬性與時間線，同時照顧好病人的情緒。
3	A	聽診器的膜面(diaphragm)主要用於聽取高頻聲音，而鐘面(bell)則用於聽取低頻聲音。臨床上醫師會依據想要分辨的聲音頻率來選擇使用哪一個面，而不是依照病患或部位的不同。
4	D	叩診能幫助分辨不同聲音：正常肺野呈現 resonance ，若有病變的話，聲音也可能會改變，因此叩診對診斷胸腔積液或肺實變特別有用；此外，叩診也能大致判斷心臟邊界與大小。至於腹部則主要用於評估是否有腸氣或腹水，但與單純測量腹圍無關。
5	B	(A) 年紀的標準寫法為 XX-year-old 。 (C) 應寫持續時間，勿寫幾月幾日。 (D) 男性用 man ，女性用 woman ，勿寫 male or female 。 【出處】共筆 11Vol.1 P.40
6	B	25 歲女性皮膚變黃七天的可能原因為黃疸，以下詳述黃疸與選項的關聯： 1) 是否有血尿：血尿提示泌尿系統疾病，不是典型黃疸鑑別診斷。 2) 眼白是否變黃：鞏膜黃染 (scleral icterus) 是黃疸 (jaundice) 的典型表現，當肝臟功能下降，無法有效排出或排除 bilirubin 時， bilirubin 就會在血液中積聚，導致鞏膜黃染。 3) 糞便顏色是否改變：糞便變淡或灰白色常見於阻塞性黃疸，因膽汁無法進入腸道，提示膽道阻塞或膽管病變。

4) 是否疲累：疲累屬於非特異性症狀，無法區分出病因或病變器官。

5) 是否有右上腹痛：右上腹痛常見於肝臟或膽道疾病，如肝炎、膽結石、膽管炎等，膽結石造成膽管阻塞時，膽汁排出受阻，可能引發黃疸和劇烈右上腹痛。

【出處】共筆無此內容；Bickley, L. S., Szilagyi, P. G., Hoffman, R. M., & Soriano, R. P. (2021). Bates' guide to physical examination and history taking, 13e. Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business. p.660

7 C 與雙側水腫有關的選項有：

1) 呼吸困難（dyspnea）或陣發性夜間呼吸困難（paroxysmal nocturnal dyspnea）是心臟衰竭（heart failure）常見症狀，這類症狀與水腫合併出現時，需高度懷疑心臟衰竭或肺高壓等心肺疾病。

2) 寡尿為腎臟功能障礙，腎病變可導致水腫，問診寡尿有助於鑑別腎源性水腫。

4) 關節痛（arthralgia）或血尿則（hematuria）為免疫或腎臟疾病（如腎小球腎炎、系統性紅斑狼瘡），這些疾病常以水腫合併關節症狀或血尿表現，問診此項有助於鑑別腎炎或自體免疫疾病。

其他選項錯誤理由如下：

3) 發燒通常是因為感染或發炎，與雙下肢水腫較無直接關聯。

5) 吞嚥疼痛與下肢水腫無直接關聯，臨床上不具鑑別診斷價值。

【出處】共筆無此內容；Bickley, L. S., Szilagyi, P. G., Hoffman, R. M., & Soriano, R. P. (2021). Bates' guide to physical examination and history taking, 13e. Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.

8 D 病例書寫順序為 Chief complaint, Present illness, Past history，其中 Review of system 是 Present illness 的一部分，如果"有"就移到 Present illness 中，寫在適當病史發生的時間，而非停留放在個別的項目中。

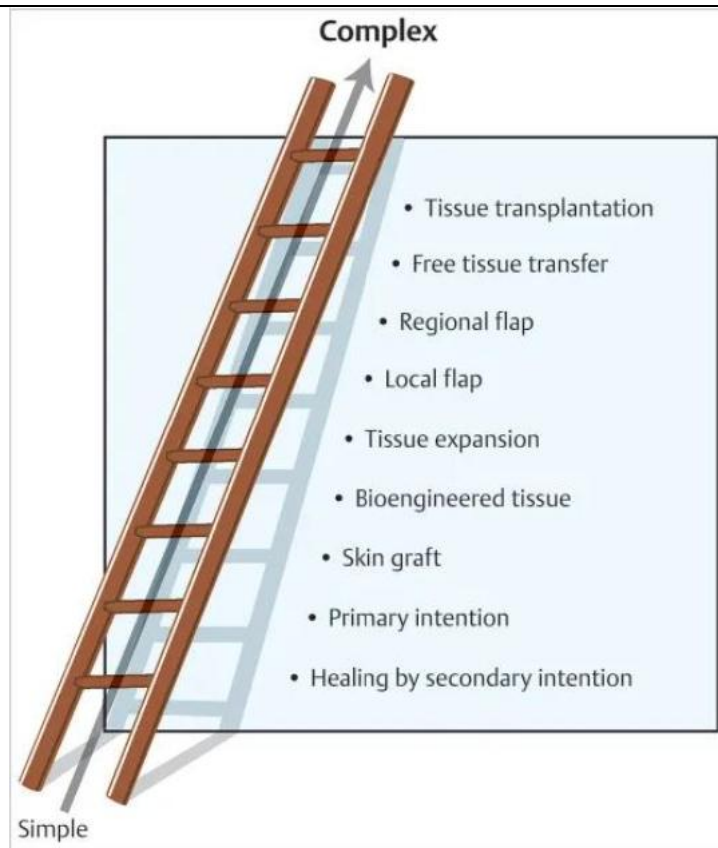
【出處】共筆 11Vol.1 P.38

- 9 C
- (A) 乾燥環境下細胞無法生長，且傷口創面滲出液含生長因子可幫助傷口癒合。
 - (B) 若傷口乾淨則無需額外用優碘、抗生素消毒，其無助於癒合且增加抗藥性細菌產生的風險。
 - (C) 對於乾淨的傷口，病人手術 48 小時後即可稍微碰水（例如沖澡），碰不碰水對預後是沒有差異的。

(D) 紗布是為了讓創面乾燥的一種素材，創面若保持乾燥，則創面上皮增生停止，且乾燥後紗布固著在創面上，更換時會產生很大的疼痛並讓傷口再度出血，破壞創面。

【出處】10 共筆 Vol.2 P.22

-
- | | | |
|----|---|--|
| 10 | B | <p>傷口癒合的分類：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Primary healing：傷口狹窄整齊，直接縫合可處理。 2. Delayed primary healing：較不乾淨的傷口，人咬傷屬於這種。 3. Secondary healing：Healing by wound contraction and epithelization，會形成 granulation tissue，容易有 scar。 4. Healing of partial-thickness wounds：部分 dermis 仍保留著，healing by re-epithelialization，擦傷、淺層燒傷這類的淺層傷口，healing 效果較 secondary healing 來得好。 <p>【出處】10 共筆 Vol.2 P.17-19</p> |
|----|---|--|
-
- | | | |
|----|---|--|
| 11 | C | <p>在傷口顏色分類系統中，外觀上有黃色腐肉為發炎期細胞死亡累積的分泌物，包含皮下脂肪死亡(鬆散濕軟)及肌肉組織被破壞(乾硬)，而不是脂肪組織。所以黃色是 sloughy/ eschar 清創感染期。脂肪組織通常呈現淡黃色或白色，但在傷口分類系統中，黃色指的是需要清除的壞死組織。</p> <p>【出處】10 共筆 Vol.2 p.25</p> |
|----|---|--|
-
- | | | |
|----|---|---|
| 12 | B | <p>Reconstructive ladder 為外科醫師要重建傷口時的處理原則，由最底層簡單的情況開始，無法補起來就往上一階走(見下圖)。在上課時老師介紹了 skin graft (從病人身上其他區域移植皮膚到傷口，要移植的皮膚會被弄的像網子一樣覆蓋在傷口上，目的是為了更大範圍的覆蓋傷口，如右下圖)、tissue expander (可促使健康組織長出額外的新組織，再拿來重建傷口，上課舉的例子為患者在頭皮下打一顆水球)、rotation flap (在傷口附近的完好皮膚劃出弧形切口，將皮瓣拉往傷口處並縫合)、free tissue transfer (將組織連同供應它的血管一起取下，移至傷口處，並將血管接好，老師提及的案例是取大網膜移至受傷到見骨的頭頂，並搭配植皮予以重建)的臨床案例。</p> <p>【出處】10 共筆 Vol.2 p.27</p> |
|----|---|---|
-



【出處】B09 共筆 Vol.3 p.36

- | | | |
|----|---|---|
| 13 | B | Growth factor 主要促進合成，屬於 anabolic hormone，其他屬於 catabolic hormone。 |
| 14 | C | 其餘三者均與急性發炎反應相關，IL-16 主要為 T cell chemoattractant，較無關。 |
| 15 | B | 定義為心跳 > 90 /min。 |
| 16 | C | 除非是切腸切胃的患者，否則宜盡早令病患自然進食，可加速復原。 |
| 17 | B | Dermis 的厚度為 1-4 mm、平均 2 mm，是皮膚最重要的一層。
【出處】B09 共筆 Vol.3 p.38 |
| 18 | C | 大面積深度燒燙傷後，皮膚受損，致水分、電解質、albumin 等無法保留在循環系統內；死亡的細胞及組織亦會放出大量 cytokines (IL-1、IL-6、IL-8、TNF- α) 造成全身性的發炎反應 (SIRS)，造成病患低血壓、周邊循環不良、休克等等，故稱 burn shock。為了避免低血壓及 hemoglobin 造成 acute tubular necrosis、並且穩定血液動力學、幫助腎臟排泄毒素等等，必須積極地給予病患 lactated Ringer's solution。
【出處】B09 Vol.3 p.37-54 |
| 19 | D | 大面積燒傷時會產生很多的 cytokine，像是 IL-1、IL-6、IL-8 和 TNF- α ，這些 cytokine 決定全身性的發炎反應。因此全身微血管滲透性都會增加，造成全身腫脹、低血壓、體液及電解質流失、滲透壓降低。
【出處】B03 考古 22 題詳解 |
| 20 | C | 適當的傷口處置，包含：使用合適的敷料，及時的焦痂切開手術、燒傷清創手術、以及重建手術。故(C)冰敷和按摩不正確。
【出處】B09 Vol.3 p.37 |

21	B	(A). ESRD 患者在手術前接受一次充分的血液透析有助於改善體液、電解質及酸鹼平衡，減少術中及術後併發症風險。 (B). ESRD 患者本身即存在多重凝血異常，包括血小板功能障礙、凝血酶生成減少及纖溶系統異常，術後出血風險顯著增加。 (C). 正確 (D). 正確 【出處】10 共筆 Vol.2 P.12
22	D	(A). 正確 (B). 正確 (C). 正確 (D). 應將手術 delayed 1 to 3 months 【出處】10 共筆 Vol.2 P.5-7

三、問答題

題號	答案	詳解
1	無	自行發揮 【出處】
2	台:nasopharynx 美:tonsil	背就對了 【出處】10 共筆 Vol.1 p.22